外科教学题库

ALL 题库（297题）

> 来源：最终产物\batch032\ALL_questions_FIXED.json ｜ 导出：2026-09-06 22:57
> 题型分布：A1×171、X×56、A2×41、B1×29
> Bloom分布：理解×117、记忆×93、应用×72、分析×15

胸部损伤、肺疾病、食管疾病（33题）

1. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_001

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P257

关于肋骨骨折的好发部位，下列叙述正确的是

- A. 第1～3肋骨最易发生骨折
- B. 第4～7肋骨最易发生骨折 ✅
- C. 第8～10肋骨最易发生骨折
- D. 第11～12肋骨最易发生骨折
- E. 肋软骨最易发生骨折

答案：B

> 解析：第1～3肋骨粗短且有锁骨、肩胛骨保护不易骨折；第4～7肋骨较长而纤薄，最易发生骨折；第8～10肋前端肋软骨形成肋弓，第11～12肋前端游离，弹性较大不易骨折。参阅教材P257。

---

2. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_002

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P258

多根多处肋骨骨折导致胸壁软化、出现反常呼吸运动，称为

- A. 开放性气胸

- B. 张力性气胸
- C. 连枷胸 ✅
- D. 损伤性血胸
- E. 肺挫伤

答案：C

> 解析：多根多处肋骨骨折指在2根或2根以上相邻肋骨各自发生2处或以上骨折，使局部胸壁失去肋骨支撑而软化，自主呼吸时出现反常运动，称为连枷胸。参阅教材P258。

---

3. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_003

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P258

连枷胸病人吸气时，软化区胸壁的运动方向是

- A. 向内凹陷 ✅
- B. 向外突出
- C. 保持不动
- D. 随纵隔摆动
- E. 随呼吸消失

答案：A

> 解析：连枷胸反常呼吸表现为吸气时软化区胸壁内陷、呼气时相对外突，导致伤员低通气甚至呼吸衰竭。参阅教材P258。

---

4. [A1型题｜理解] batch032_M1_A1_004

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P258

根据病理生理特点，创伤性气胸一般不包括下列哪一型

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 自发性气胸 ✅

- E. 高压性气胸

答案：D

> 解析：创伤性气胸分为闭合性、开放性和张力性三类，张力性气胸又称高压性气胸；自发性气胸多因肺大疱破裂等非创伤因素所致，不属于创伤性气胸分类。参阅教材P258。

---

5. [A1型题｜理解] batch032_M1_A1_005

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P259

开放性气胸病人吸气时，纵隔的移动方向是

- A. 向健侧移位 ✅
- B. 向伤侧移位
- C. 无移位
- D. 向头侧移位
- E. 向膈下移位

答案：A

> 解析：开放性气胸时呼、吸气出现两侧胸膜腔压力不均衡的周期性变化，吸气时纵隔移向健侧、呼气时移向伤侧，称为纵隔扑动，可影响腔静脉回心血流量。参阅教材P259。

---

6. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_006

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P259

开放性气胸的现场急救首要措施是

- A. 立即清创缝合
- B. 立即开胸探查
- C. 立即行胸腔闭式引流
- D. 立即气管插管
- E. 立即闭合胸壁伤口 ✅

答案：E

> 解析：开放性气胸急救处理要点是立即闭合胸壁伤口，将开放性气胸变为闭合性气胸，赢得挽救生命的时间并迅速转送医院。参阅教材P259。

---

7. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_007

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P259

气胸行胸腔闭式引流时，引流管通常置于

- A. 锁骨中线第2肋间 ✅
- B. 腋中线第6肋间
- C. 腋后线第7肋间
- D. 肩胛线第8肋间
- E. 胸骨旁线第3肋间

答案：A

> 解析：胸腔闭式引流术气胸引流一般在前胸壁锁骨中线第2肋间隙，血胸引流则在腋中线与腋后线间第6或第7肋间隙。参阅教材P259。

---

8. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_008

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P260

张力性气胸的紧急处理措施是

- A. 立即胸腔穿刺抽气
- B. 立即气管插管
- C. 立即行胸腔闭式引流
- D. 立即开胸探查
- E. 粗针头穿刺胸膜腔减压 ✅

答案：E

> 解析：张力性气胸是可迅速致死的危急重症，入院前或院内急救需迅速使用粗针头穿刺胸膜腔减压，并外接单向活瓣装置。参阅教材P260。

9. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_009

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P260

成人血胸中，中量血胸的胸腔积血量范围是

- A. ≤300ml
- B. ≤500ml
- C. 500～1000ml ✅
- D. ＞1000ml
- E. ＞2000ml

答案：C

> 解析：成人血胸量≤500ml为少量血胸，500ml～1000ml为中量血胸，＞1000ml为大量血胸。参阅教材P260。

---

10. [A1型题｜理解] batch032_M1_A1_010

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P261

提示存在进行性血胸的胸腔闭式引流量标准是

- A. 每小时超过100ml持续2小时
- B. 每小时超过200ml持续3小时 ✅
- C. 每小时超过300ml持续1小时
- D. 每小时超过50ml持续5小时
- E. 24小时超过500ml

答案：B

> 解析：具备以下征象提示进行性血胸：持续脉搏加快、血压降低；胸腔闭式引流量每小时超过200ml、持续3小时；血红蛋白、红细胞计数和血细胞比容进行性降低。参阅教材P261。

---

11. [A1型题｜理解] batch032_M1_A1_011

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P261

感染性血胸时，胸腔积血中红细胞与白细胞计数比例约为

- A. 500∶1
- B. 100∶1 ✅
- C. 50∶1
- D. 10∶1
- E. 1∶1

答案：B

> 解析：无感染时胸腔积血红细胞与白细胞计数比例与周围血相似，约500∶1；感染时白细胞计数明显增加，比例达100∶1可确定为感染性血胸。参阅教材P261。

---

12. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_012

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P264

漏斗胸诊断中，Haller指数的正常平均值约为

- A. 1.52
- B. 2.52 ✅
- C. 3.52
- D. 4.52
- E. 5.52

答案：B

> 解析：Haller指数为胸骨最凹陷平面胸廓横径与同层面胸骨后缘到椎体前缘距离之比，正常人平均约2.52，大于3.2可诊断漏斗胸。参阅教材P264。

---

13. [A1型题｜记忆] batch032_M1_A1_015

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P268

原发性胸壁骨组织肿瘤中，原发于肋骨者约占

- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80% ✅
- E. 95%

答案：D

> 解析：原发性胸壁肿瘤中原发于骨组织者80%起源于肋骨、20%起源于胸骨。参阅教材P268。

---

14. [A1型题｜理解] batch032_M1_A1_016

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P275

目前发病率已超越鳞癌成为最常见肺癌的病理类型是

- A. 鳞癌
- B. 小细胞癌
- C. 腺癌 ✅
- D. 大细胞癌
- E. 腺鳞癌

答案：C

> 解析：腺癌近年来发病率上升明显，已超越鳞癌成为最常见的肺癌，多为周围型，一般生长较慢但有时在肿瘤较小时即发生血行和淋巴转移。参阅教材P275。

---

15. [A1型题｜理解] batch032_M1_A1_017

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P275

关于小细胞癌的叙述，正确的是

- A. 多为周围型，女性多见
- B. 恶性程度低，生长缓慢

- C. 神经内分泌起源，化放疗敏感 ✅
- D. 血行转移发生较晚
- E. 首选外科手术治疗

答案：C

> 解析：小细胞癌为神经内分泌起源，恶性程度高、生长快、很早出现淋巴和血行转移，对放射和化学治疗虽较敏感但可迅速耐药，预后差；除早期外以非手术治疗为主。参阅教材P275。

---

16. [A1型题｜理解] batch032_M1_A1_018

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病｜页码：教材P275

肺癌淋巴转移时最常累及的淋巴结是

- A. 锁骨上淋巴结 ✅
- B. 腋窝淋巴结
- C. 腹股沟淋巴结
- D. 肠系膜淋巴结
- E. 腘窝淋巴结

答案：A

> 解析：肺癌淋巴转移先侵入肺段或肺叶支气管周围淋巴结，再到肺门和纵隔淋巴结，最后累及锁骨上前斜角肌淋巴结和颈部淋巴结。参阅教材P275。

---

17. [A1型题｜应用] batch032_M1_A1_019

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病｜页码：教材P276

目前公认肺癌筛查最有效的手段是

- A. 胸部X线平片
- B. 低剂量胸部CT ✅
- C. 磁共振成像
- D. PET-CT
- E. 痰细胞学检查

答案：B

> 解析：低剂量胸部CT是目前肺癌筛查最有效的手段，可发现肺内早期病变，通过早发现、早诊断、早治疗降低肺癌病人病死率。参阅教材P276。

---

18. [A1型题｜应用] batch032_M1_A1_020

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P283

我国食管癌高发区最常见的病理类型是

- A. 腺癌
- B. 鳞癌 ✅
- C. 小细胞癌
- D. 腺鳞癌
- E. 未分化癌

答案：B

> 解析：高发区（如中国）食管癌以鳞癌为主，占80%以上；非高发区（美国和欧洲）以腺癌为主，占70%以上。参阅教材P283。

---

19. [A1型题｜分析] batch032_M1_A1_021

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P275

男性，62岁。体检时发现右锁骨上淋巴结肿大，无压痛。淋巴结切除送检，病理诊断：淋巴结内可见腺癌浸润。肿瘤原发部位最可能是

- A. 食管
- B. 胃
- C. 肝
- D. 肺 ✅
- E. 乳腺

答案：D

> 解析：①肺癌常转移至右锁骨上淋巴结，胃癌、食管癌常经胸导管转移至左锁骨上淋巴结，故答D。乳腺癌亦可转移至锁骨上淋巴结，但右锁骨上淋巴结腺癌浸润以肺癌最常见。参阅教材P275。[源:考研真题 GS-2023-032]

---

20. [A2型题｜应用] batch032_M1_A2_001

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P258

男性，45岁。车祸致胸部撞击，诉胸痛、呼吸浅快。查体：右侧胸壁第4～7肋处可见反常呼吸运动，吸气时局部内陷。最可能的诊断是

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 连枷胸 ✅
- D. 张力性气胸
- E. 损伤性血胸

答案：C

> 解析：多根多处肋骨骨折使局部胸壁失去支撑而软化，出现吸气时内陷、呼气时外突的反常呼吸运动，称为连枷胸。本例第4～7肋多发骨折伴反常呼吸，符合连枷胸。参阅教材P258。

---

21. [A2型题｜应用] batch032_M1_A2_002

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P259

男性，30岁。被刀刺伤左胸壁，呼吸时有气体进出伴吸吮样声响，呼吸困难、发绀。现场急救最关键的处理是

- A. 立即气管切开
- B. 立即胸腔穿刺抽气
- C. 立即静脉补液
- D. 加压包扎并封闭伤口 ✅
- E. 立即应用抗生素

答案：D

> 解析：本例为开放性气胸（胸部吸吮性伤口）。急救要点是立即用不透气敷料在伤员用力呼气末封盖伤口、加压包扎，将开放性气胸变为闭合性气胸，赢得抢救时间。参阅教材P259。

---

22. [A2型题｜应用] batch032_M1_A2_003

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P260

男性，25岁。高处坠落伤后极度呼吸困难、烦躁、发绀，气管明显向健侧移位，颈静脉怒张，伤侧叩诊鼓音。最可能的诊断是

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 张力性气胸 ✅
- D. 损伤性血胸
- E. 连枷胸

答案：C

> 解析：张力性气胸为气管、支气管或肺损伤处形成活瓣，气体随吸气积累致胸膜腔压力高于大气压，表现为严重呼吸困难、发绀、气管向健侧移位、颈静脉怒张、皮下气肿，是可迅速致死的危急重症。参阅教材P260。

---

23. [A2型题｜应用] batch032_M1_A2_004

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P261

男性，35岁。车祸伤后行胸腔闭式引流，引流液每小时约250ml，已持续4小时，血红蛋白持续下降。最可能的诊断是

- A. 凝固性血胸
- B. 感染性血胸
- C. 进行性血胸 ✅
- D. 迟发性血胸
- E. 自发性血胸

答案：C

> 解析：持续大量出血所致胸膜腔积血称进行性血胸，征象包括胸腔闭式引流量每小时超过200ml、持续3小时，且血红蛋白、红细胞计数进行性降低。本例符合。参阅教材P261。

---

24. [A2型题｜分析] batch032_M1_A2_005

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P275

男性，60岁。刺激性咳嗽2个月，痰中带血，近1周出现声音嘶哑。胸部CT示右肺门肿块。声音嘶哑最可能的原因是

- A. 上腔静脉受压迫
- B. 膈神经受侵犯
- C. 食管受压迫
- D. 喉返神经受侵犯 ✅
- E. 气管受压迫

答案：D

> 解析：肺癌局部晚期压迫或侵犯喉返神经，可引起声带麻痹、声音嘶哑；压迫膈神经致同侧膈肌麻痹，侵犯食管致吞咽困难，压迫上腔静脉致上腔静脉阻塞综合征。本例声嘶符合喉返神经受侵。参阅教材P275。

---

25. [B1型题｜记忆] batch032_M1_B1_001a

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P290

胸腺瘤最好发于：

- A. 前上纵隔 ✅
- B. 中纵隔
- C. 后纵隔
- D. 前纵隔
- E. 心包腔内

答案：A

> 解析：胸腺瘤是多发于前上纵隔的肿瘤，约15%的病人合并重症肌无力。参阅教材P290。

26. [B1型题｜记忆] batch032_M1_B1_001b

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P290

神经源性肿瘤最好发于：

- A. 前上纵隔
- B. 中纵隔
- C. 后纵隔 ✅
- D. 前纵隔
- E. 心包腔内

答案：C

> 解析：神经源性肿瘤多位于后纵隔脊柱旁肋脊区内，以单侧多见，可分为自主神经系统肿瘤和周围神经来源肿瘤。参阅教材P290。

---

27. [B1型题｜理解] batch032_M1_B1_001c

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P291

畸胎瘤与皮样囊肿最好发于：

- A. 前上纵隔
- B. 中纵隔
- C. 后纵隔
- D. 前纵隔 ✅
- E. 心包腔内

答案：D

> 解析：畸胎瘤与皮样囊肿多位于前纵隔，接近心底部的心脏大血管前方，囊内可含皮脂、胆固醇结节及毛发。参阅教材P291。

---

28. [X型题｜理解] batch032_M1_X_001

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P257

关于肋骨骨折，下列说法正确的有

- A. 第4～7肋骨较长而纤薄，易发生骨折 ✅
- B. 多根多处肋骨骨折可致连枷胸 ✅
- C. 骨折断端向内移位可刺破胸膜产生气胸 ✅
- D. 第1～3肋骨因有锁骨保护不易骨折 ✅
- E. 连枷胸可出现纵隔扑动

答案：ABCD

> 解析：A正确：第4～7肋骨较长纤薄易骨折。B正确：多根多处肋骨骨折致胸壁软化即连枷胸。C正确：骨折断端向内移位可刺破胸膜、肺组织产生气胸、血胸。D正确：第1～3肋骨有锁骨、肩胛骨保护不易骨折。E错误：纵隔扑动是开放性气胸的特征，连枷胸表现为反常呼吸运动。参阅教材P257。

---

29. [X型题｜理解] batch032_M1_X_002

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病 | 页码：教材P258

关于气胸的描述，正确的有

- A. 闭合性气胸胸壁伤口已闭合 ✅
- B. 开放性气胸可引起纵隔扑动 ✅
- C. 张力性气胸胸膜腔压力高于大气压 ✅
- D. 张力性气胸又称高压性气胸 ✅
- E. 开放性气胸需立即开胸探查

答案：ABCD

> 解析：A正确：闭合性气胸胸壁伤口闭合、裂口缩小至不开放。B正确：开放性气胸呼吸时两侧胸膜腔压力不均衡致纵隔扑动。C、D正确：张力性气胸胸膜腔压力高于大气压，又称高压性气胸。E错误：开放性气胸急救先闭合伤口，仅气胸持续存在、疑内脏损伤或进行性出血才考虑开胸探查。参阅教材P258。

---

30. [X型题｜理解] batch032_M1_X_004

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病｜页码：教材P274

关于肺癌病理类型，下列说法正确的有

- A. 鳞癌多与吸烟有关，常为中心型 ✅
- B. 腺癌多为周围型，血行转移较早 ✅
- C. 小细胞癌恶性程度高，预后差 ✅
- D. 腺癌目前已为最常见肺癌 ✅
- E. 小细胞癌以手术治疗为首选

答案：ABCD

> 解析：A正确：鳞癌与吸烟关系密切，大多起源于较大支气管，常为中心型。B正确：腺癌多为周围型，有时肿瘤较小时即发生血行和淋巴转移。C正确：小细胞癌恶性程度高、预后差。D正确：腺癌发病率已超越鳞癌成为最常见肺癌。E错误：小细胞癌除早期外以非手术治疗为主，并非首选手术。参阅教材P274。

---

31. [X型题｜应用] batch032_M1_X_005

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病｜页码：教材P276

可用于肺癌病理分期及淋巴结分期的检查有

- A. 胸部CT检查 ✅
- B. PET-CT检查 ✅
- C. EBUS-TBNA ✅
- D. 纵隔镜检查 ✅
- E. 全身骨扫描

答案：ABCD

> 解析：A正确：CT可评估肿瘤范围、与邻近器官关系及淋巴结转移。B正确：PET-CT用于肺癌分期、转移灶检测。C正确：EBUS-TBNA对纵隔或肺门淋巴结细针穿刺活检用于病理及分期。D正确：纵隔镜直视下淋巴结活检明确有无转移。E错误：骨扫描是骨转移筛查手段，不直接用于淋巴结分期。参阅教材P276。

---

32. [X型题｜理解] batch032_M1_X_006

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P283

关于食管癌，下列说法正确的有

- A. 我国高发区以鳞癌为主 ✅
- B. 胸中段食管癌较多见 ✅
- C. 进行性吞咽困难是典型症状 ✅
- D. 淋巴结转移为主要扩散途径 ✅
- E. 腺癌是我国高发区主要类型

答案：ABCD

> 解析：A、B正确：我国高发区以鳞癌为主（＞80%），胸中段多见、下段次之。C正确：中晚期典型症状为进行性吞咽困难。D正确：癌转移主要经淋巴途径。E错误：高发区以鳞癌为主，腺癌为非高发区主要类型。参阅教材P283。

---

33. [X型题｜理解] batch032_M1_X_007

> 模块：胸部损伤、肺疾病、食管疾病丨页码：教材P289

下列纵隔肿瘤与其特征性表现相符的有

- A. 胸腺瘤可伴重症肌无力 ✅
- B. 畸胎瘤破入支气管可咳出毛发 ✅
- C. 胸骨后甲状腺肿随吞咽上下活动 ✅
- D. 神经源性肿瘤多位于后纵隔 ✅
- E. 淋巴瘤宜首选手术治疗

答案：ABCD

> 解析：A正确：约15%胸腺瘤合并重症肌无力。B正确：畸胎瘤破入支气管可使病人咳出皮脂物及毛发。C正确：胸骨后甲状腺肿可随吞咽运动上下活动。D正确：神经源性肿瘤多位于后纵隔。E错误：淋巴源性肿瘤多为恶性，不宜手术，多采用放疗或化疗。参阅教材P289。

腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病（42题）

34. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_001

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：考研真题/GS-1998-086

急性阑尾炎可发生的并发症不包括下列哪项？

- A. 腹腔脓肿
- B. 腹腔内出血 ✅
- C. 内瘘形成
- D. 外瘘形成
- E. 门静脉炎

答案：B

> 解析：急性阑尾炎的并发症包括腹腔脓肿、内瘘形成、外瘘形成、门静脉炎等。腹腔内出血为阑尾切除术后并发症，而非急性阑尾炎本身的并发症，故答B。[源:考研真题 GS-1998-086]

---

35. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_002

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P346

男性，65岁。因右腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊的一部分由盲肠构成。应诊断为

- A. 肠管壁疝
- B. 难复性疝
- C. 逆行性嵌顿疝
- D. 腹内疝
- E. 滑动性疝 ✅

答案：E

> 解析：疝内容物（如盲肠）构成疝囊壁的一部分，称为滑动性疝，故答§。肠管壁疝（Richter疝）嵌顿内容物为部分肠壁；逆行性嵌顿疝（Maydl疝）嵌顿肠袢呈W形；腹内疝为脏器进入腹腔内间隙囊。[源:考研真题 GS-2024-064]

---

36. [X型题｜理解] batch032_M2_X_001

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病 | 页码：考研真题/GS-2023-161

急性阑尾炎可能出现的阳性体征有

- A. Rovsing征 ✅
- B. Cullen征
- C. Psoas征 ✅
- D. Obturator征 ✅

答案：ACD

> 解析：结肠充气试验（Rovsing征）阳性提示急性阑尾炎；腰大肌试验（Psoas征）阳性提示阑尾位置深、盲肠后位或腹膜后位；闭孔内肌试验（Obturator征）阳性提示阑尾位置较低、靠近闭孔内肌。Cullen征阳性常见于急性出血坏死性胰腺炎，故不入选。[源:考研真题 GS-2023-161]

---

37. [X型题｜理解] batch032_M2_X_002

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病 | 页码：考研真题/GS-2022-161

关于老年人急性阑尾炎的叙述，正确的有

- A. 体征不典型 ✅
- B. 腹痛程度较轻 ✅
- C. 症状轻、病理改变重 ✅
- D. 尽量采取保守治疗

答案：ABC

> 解析：老年人对疼痛感觉迟钝、腹肌薄弱、防御功能减退，故主诉不强烈、体征不典型，临床表现轻而病理改变重。老年人动脉硬化、阑尾动脉改变，易缺血坏死，应及时手术治疗而非保守，故D错误。[源:考研真题 GS-2022-161]

---

38. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_003

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病 | 页码：考研真题/GS-2020-060

青少年容易发生急性阑尾炎的原因中，最重要的是

- A. 阑尾发育尚不健全
- B. 寄生虫造成阑尾梗阻
- C. 粪石阻塞阑尾管腔
- D. 阑尾淋巴滤泡组织增生致阑尾梗阻 ✅
- E. 阑尾异物阻塞管腔

答案：D

> 解析：阑尾管腔阻塞是急性阑尾炎最常见病因，阻塞最常见原因是淋巴滤泡明显增生（约占60%），青少年尤甚；肠石阻塞约占35%，粪石、寄生虫少见；阑尾发育不健全为少见原因，故答D。[源:考研真题 GS-2020-060]

---

39. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_004

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P349

最容易发生嵌顿的腹外疝是

- A. 脐疝
- B. 直疝
- C. 斜疝
- D. 股疝 ✅
- E. 切口疝

答案：D

> 解析：股疝疝囊经股环、股管向卵圆窝突出。股管几垂直，疝块在卵圆窝处向前转折成锐角，股环小且周围多坚韧韧带，故易嵌顿。腹外疝中股疝嵌顿者最多，高达60%，故答D。[源:考研真题 GS-2017-061]

---

40. [X型题｜应用] batch032_M2_X_003

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：考研真题/GS-2016-178

应尽早手术的阑尾炎有

- A. 儿童急性阑尾炎 ✅
- B. 老年人急性阑尾炎 ✅
- C. 妊娠35周的急性阑尾炎 ✅
- D. 右下腹可触到包块的阑尾炎

答案：ABC

> 解析：小儿急性阑尾炎病情发展快、穿孔率高；老年人易缺血坏死；妊娠期阑尾炎易致流产早产、感染难控，三者均应及时手术。右下腹可触包块提示阑尾周围脓肿，病情稳定宜保守治疗，强行切除易致肠瘘，故D不选。[源:考研真题 GS-2016-178]

---

41. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_005

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病 | 页码：考研真题/GS-2015-081

诊断急性阑尾炎最有意义的体征是

- A. 右下腹固定压痛 ✅
- B. 腰大肌试验阳性
- C. 结肠充气试验阳性
- D. 闭孔肌试验阳性
- E. 局限性腹肌紧张

答案：A

> 解析：右下腹固定压痛是急性阑尾炎最常见且最有诊断价值的体征。腰大肌、结肠充气、闭孔肌试验为辅助定位体征，故答A。[源:考研真题 GS-2015-081]

---

42. [X型题｜应用] batch032_M2_X_004

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病 | 页码：考研真题/GS-2014-175

慢性阑尾炎钡剂灌肠X线表现有

- A. 阑尾充盈不全 ✅
- B. 阑尾排空延迟超3天 ✅
- C. 阑尾腔不规则 ✅

- D. 阑尾不充盈 ✅

答案：ABCD

> 解析：钡剂灌肠是慢性阑尾炎重要检查。阑尾不充盈、充盈不完全、阑尾腔不规则、72小时（3天）以上仍有钡剂残留（排空延迟）均支持慢性阑尾炎诊断，四项均入选。[源:考研真题 GS-2014-175]

---

43. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_006

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：考研真题/GS-2013-145

6岁儿童诊断为急性阑尾炎，治疗应选择

- A. 抗生素治疗观察
- B. 保守无效再手术
- C. 中药保守治疗
- D. 尽早手术切除 ✅
- E. 禁食胃肠减压

答案：D

> 解析：小儿急性阑尾炎病情发展快且重、穿孔率高、并发症及死亡率高，主张早期手术治疗，故答D。抗生素保守治疗仅用于单纯性阑尾炎早期。[源:考研真题 GS-2013-145]

---

44. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_007

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：考研真题/GS-2011-086

下列肠梗阻表现中，提示发生肠绞窄可能性较小的是

- A. 发病急、疼痛重而持续
- B. 腹膜刺激征明显，有休克表现
- C. 呕吐物为血性液体
- D. 有多次腹部手术史，反复发作腹痛 ✅
- E. 肠鸣音减弱或消失

答案：D

> 解析：单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻区别在于有无血运障碍。发病急重持续痛、腹膜刺激征伴休克、血性呕吐物均提示绞窄。多次腹部手术史、反复发作腹痛提示不全性单纯性肠梗阻，绞窄可能小，故答D。[源:考研真题 GS-2011-086]

---

45. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_008

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：考研真题/GS-2009-086

患者，女，28岁。宫内孕27周，右侧腹痛30小时，伴发热38℃，恶心，未吐。查体：宫底脐上二指，右侧腹部压痛(+)，无包块，白细胞$10.8\times10^{9}/L$，诊断为急性阑尾炎。下列处理中，不恰当的是

- A. 使用广谱抗生素
- B. 禁食胃肠减压
- C. 使用黄体酮
- D. 阑尾切除术
- E. 剖宫产加阑尾切除术 ✅

答案：E

> 解析：妊娠中期急性阑尾炎应早期行阑尾切除术，围术期加用黄体酮保胎、术后广谱抗生素。孕27周无早产征象，不应行剖宫产，故答§。[源:考研真题 GS-2009-086]

---

46. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_009

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P344

发生率最高的疝是

- A. 斜疝 ✅
- B. 直疝
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 脐疝

答案：A

> 解析：腹股沟斜疝是最多见的腹外疝，占全部腹外疝75%～90%；直疝约5%，股疝3%～5%，切口疝更少见，故答A。[源:考研真题 GS-2009-147]

---

47. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_010

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P345

关于直疝三角（Hesselbach三角）的解剖边界，正确的是

- A. 外侧边为腹壁下动脉 ✅
- B. 外侧边为髂腹下神经
- C. 内侧边为腹股沟韧带
- D. 底边为腹直肌外侧缘
- E. 内侧边为腹壁下动脉

答案：A

> 解析：直疝三角外侧边为腹壁下动脉，内侧边为腹直肌外侧缘，底边为腹股沟韧带。腹股沟直疝由此由后向前突出。[源:教材P345]

---

48. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_011

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P344

关于腹股沟斜疝的流行病学特点，正确的是

- A. 占全部腹外疝的75%～90% ✅
- B. 男女发病率之比约为1∶15
- C. 左侧比右侧多见
- D. 占腹股沟疝的5%左右
- E. 多见于老年女性

答案：A

> 解析：斜疝最多见，占腹外疝75%～90%、占腹股沟疝85%～95%；男女之比约15∶1；右侧比左侧多见。[源:教材P344]

49. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_012

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P343

嵌顿的小肠为小肠憩室（通常为Meckel憩室）时，称为

- A. Richter疝
- B. Amyand疝
- C. Maydl疝
- D. Littre疝 ✅
- E. 滑动性疝

答案：D

> 解析：嵌顿内容物为小肠憩室（多为Meckel憩室）称Littre疝；肠管壁部分肠壁嵌顿为Richter疝；呈W形逆行嵌顿为Maydl疝；内容物为阑尾为Amyand疝。[源:教材P343]

---

50. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_013

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P346

关于滑动性疝的临床特点，正确的是

- A. 多见于左侧
- B. 右多于左侧约6倍 ✅
- C. 疝块可完全回纳
- D. 老年人多见
- E. 嵌顿率最高

答案：B

> 解析：滑动性疝除不能完全回纳外，尚有消化不良、便秘；多见于右侧，左右之比约1：6，手术时易误切疝内容物。[源:教材P346]

---

51. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_014

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P348

临床应用最广的加强腹股沟管后壁的传统疝修补术是

- A. Ferguson法
- B. Shouldice法
- C. Halsted法
- D. McVay法
- E. Bassini法 ✅

答案：E

> 解析：Bassini法在精索后方将腹内斜肌下缘和联合腱缝至腹股沟韧带，临床应用最广泛；Ferguson加强前壁；McVay用于后壁薄弱及股疝；Shouldice复发率低。[源:教材P348]

---

52. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_015

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P350

关于股疝的临床特点，错误的是

- A. 发病率约占腹外疝3%～5%
- B. 多见于40岁以上妇女
- C. 疝块位于腹股沟韧带上内方 ✅
- D. 股管长约1～1.5cm
- E. 嵌顿率高达60%

答案：C

> 解析：股疝疝块位于腹股沟韧带下方卵圆窝处（下外方）；斜疝位于腹股沟韧带上内方。股疝经股环、股管突出，股管长1～1.5cm，嵌顿率高达60%。[源:教材P349-350]

---

53. [A2型题｜应用] batch032_M2_A2_001

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P349

男性，45岁。右腹股沟区可复性肿块3年，突发肿块增大、疼痛、不能回纳6小时，无发热及明显腹膜刺激征。查体：右腹股沟韧带上内方肿块，紧张发硬，压痛轻。最恰当的首要处理是

- A. 立即手法复位
- B. 禁食胃肠减压
- C. 抗感染观察
- D. 疝带压迫
- E. 急诊手术治疗 ✅

答案：E

> 解析：嵌顿疝原则上应紧急手术以防内容物坏死及肠梗阻。手法复位仅适用于嵌顿3～4小时内、压痛不明显、无腹膜刺激征且估计未绞窄的年老体弱者；本例嵌顿6小时，应手术。[源:教材P349]

---

54. [A2型题｜应用] batch032_M2_A2_002

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P347

男性，72岁。直立时腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现半球形肿块，平卧后消失，无疼痛。压住深环后咳嗽肿块仍可突出。最可能的诊断是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝 ✅
- C. 股疝（经股管）
- D. 睾丸鞘膜积液
- E. 交通性鞘膜积液

答案：B

> 解析：老年、耻骨结节上外方半球形肿块、压深环后仍能突出，符合直疝（直疝三角突出，不进阴囊，极少嵌顿）；斜疝压深环后不再突出。[源:教材P347]

---

55. [B1型题｜理解] batch032_M2_B1_001

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P347

疝囊颈位于腹壁下动脉外侧，疝块可随之下行并进入阴囊，见于：

- A. 斜疝 ✅
- B. 直疝
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 脐疝

答案：A

> 解析：斜疝疝囊经深环突出，向内下前斜行经腹股沟管，可入阴囊；疝囊颈在腹壁下动脉外侧。[源:教材P347]

---

56. [B1型题｜理解] batch032_M2_B1_002

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P347

2：疝块由腹股沟内侧突出，极少进入阴囊，压住深环后疝块仍可突出，见于：

- A. 斜疝
- B. 直疝 ✅
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 脐疝

答案：B

> 解析：直疝由直疝三角突出，疝囊颈在腹壁下动脉内侧，极少入阴囊，压深环后疝块仍可突出。[源:教材P347]

---

57. [X型题｜应用] batch032_M2_X_005

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P349

关于嵌顿性和绞窄性疝手术处理，正确的有

- A. 嵌顿3～4小时内、无腹膜刺激征者可行手法复位 ✅

- B. 绞窄性疝内容物已坏死应立即手术 ✅
- C. 嵌顿肠袢较多时需检查腹腔内中间肠袢活力 ✅
- D. 行肠切除者一般不宜同期无张力疝修补 ✅
- E. 嵌顿疝原则上均应紧急手术

答案：ABCD

> 解析：嵌顿3～4小时内、压痛不明显、无腹膜刺激征、估计未绞窄者可先手法复位（A）。绞窄坏死立即手术（B）。嵌顿肠袢多须警惕逆行性嵌顿，检查腹腔内中间肠袢（C）。肠切除者因污染一般不宜无张力修补（D）。嵌顿疝原则上紧急手术，但具备适应证者可行手法复位，故E“均应”不准确。[源:教材P349]

---

58. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_016

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P364

急性化脓性腹膜炎中最多见、最常见的类型是

- A. 原发性腹膜炎
- B. 肠间脓肿
- C. 盆腔脓肿
- D. 膈下脓肿
- E. 继发性腹膜炎 ✅

答案：E

> 解析：继发性腹膜炎最常见，由空腔脏器穿孔、外伤破裂、脏器炎症扩散所致；原发性腹膜炎无原发病灶。[源:教材P364]

---

59. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_017

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P365

腹膜炎典型的腹部体征是

- A. 腹部包块伴肠型
- B. 压痛、反跳痛及肌紧张 ✅

- C. 移动性浊音阳性
- D. 肝浊音界扩大
- E. 肠鸣音亢进

答案：B

> 解析：腹膜刺激征即压痛、反跳痛、腹肌紧张，以原发病灶处最明显，是腹膜炎典型体征。[源:教材P365]

---

60. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_018

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P366

急性阑尾炎穿孔致弥漫性腹膜炎时，诊断性腹腔穿刺抽出的液体性状多为

- A. 草绿色透明腹水
- B. 黄色混浊含胆汁
- C. 稀薄脓性微臭液 ✅
- D. 血性且淀粉酶升高
- E. 腹腔内不凝血

答案：C

> 解析：阑尾炎穿孔抽出液为稀薄脓性、略有臭味；结核性腹膜炎为草绿色透明；胃十二指肠穿孔为黄色混浊含胆汁无臭；重症胰腺炎为血性淀粉酶高；不凝血提示腹腔内出血。[源:教材P366]

---

61. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_019

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P368

胃穿孔和脾切除术后感染，脓肿常发生在

- A. 右膈下
- B. 盆腔
- C. 左膈下 ✅
- D. 肠间

- E. 结肠旁沟

答案：C

> 解析：十二指肠溃疡穿孔、胆囊及胆管感染、阑尾炎穿孔脓液常积聚右膈下；胃穿孔和脾切除术后感染，脓肿常发生在左膈下。[源:教材P368]

---

62. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_020

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P369

关于盆腔脓肿的临床特点，正确的是

- A. 全身中毒症状最重
- B. 腹部体征明显
- C. 直肠前壁可及肿物 ✅
- D. 膈下可见占位阴影
- E. 多见于胃穿孔后

答案：C

> 解析：盆腔腹膜炎面积小、吸收毒素弱，全身中毒症状较轻；直肠指诊可触及直肠前壁向腔内膨起、有触痛或波动感的肿物。盆腔脓肿继发于阑尾穿孔或结直肠术后。[源:教材P369]

---

63. [A2型题｜应用] batch032_M2_A2_003

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P380

男性，38岁。突发上腹部刀割样剧痛2小时，迅速波及全腹。查体：板状腹，全腹压痛反跳痛，肝浊音界缩小，肠鸣音消失。立位腹平片见膈下游离气体。最可能的诊断是

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 溃疡急性穿孔 ✅
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性肠梗阻

答案：C

> 解析：溃疡病史+刀割样剧痛+板状腹+肝浊音界缩小+膈下游离气体，符合胃十二指肠溃疡急性穿孔所致化学性腹膜炎。胆囊炎、胰腺炎无膈下游离气体；阑尾炎无板样强直。[源:教材P380]

---

64. [A2型题｜分析] batch032_M2_A2_004

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P368

女性，55岁。急性腹膜炎行阑尾穿孔切除术后第9天，出现发热、畏寒、胸骨后及右肩部放射痛，右侧胸部呼吸音减弱。X线见肝下间隙局限性液平。最可能的诊断是

- A. 盆腔脓肿
- B. 肠间脓肿
- C. 右膈下脓肿 ✅
- D. 胸腔积液
- E. 肝脓肿

答案：C

> 解析：阑尾穿孔后脓液常积聚右膈下；术后数日发热、肩部放射痛、右膈下占位阴影，符合右膈下脓肿。盆腔脓肿以直肠刺激为主；肠间脓肿腹胀腹痛；需与肝脓肿、胸腔积液鉴别。[源:教材P368]

---

65. [X型题｜应用] batch032_M2_X_006

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P367

关于继发性化脓性腹膜炎，正确的有

- A. 空腔脏器穿孔是最常见原因 ✅
- B. 主要致病菌为大肠埃希菌等混合感染 ✅
- C. 半卧位可促使渗液流向盆腔 ✅
- D. 非手术24小时体征减轻可保守 ✅
- E. 抗生素可替代手术治疗

答案：ABCD

> 解析：继发性腹膜炎最常见于空腔脏器穿孔；致病菌以大肠埃希菌、肠球菌、厌氧菌为主，多为混合感染；半卧位使渗液流向盆腔、减轻中毒；病情轻或超24小时且体征减轻者可非手术治疗。抗生素不能替代手术（E错）。[源:教材P364、367]

---

66. [A1型题｜记忆] batch032_M2_A1_021

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P374

女性胃癌病人发生卵巢转移性肿瘤（Krukenberg瘤）的主要转移途径是

- A. 血行转移
- B. 腹膜种植转移 ✅
- C. 淋巴转移
- D. 直接浸润
- E. 神经束膜播散

答案：B

> 解析：胃癌组织浸润至浆膜外后，癌细胞脱落并种植于腹膜和脏器浆膜形成转移结节；女性病人可经此途径形成卵巢转移性肿瘤，称Krukenberg瘤。淋巴转移与血行转移（以肝转移多见）为其他扩散途径。[源:教材P374]

---

67. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_022

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P374

关于早期胃癌的定义，正确的是

- A. 癌灶直径小于2cm
- B. 病变仅限于黏膜或黏膜下层 ✅
- C. 无淋巴结转移
- D. 肉眼为隆起型
- E. 浸润不超过固有肌层

答案：B

> 解析：早期胃癌指病变仅限于黏膜或黏膜下层，不论有无淋巴结转移及大小；进展期胃癌浸润超过黏膜下层。[源:教材P374]

---

68. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_023

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P380

关于胃十二指肠溃疡的临床特点，正确的是

- A. 胃溃疡多见于青壮年
- B. 十二指肠溃疡多见于40～60岁
- C. 胃溃疡有癌变可能 ✅
- D. 十二指肠溃疡癌变率高
- E. 胃溃疡好发于球部

答案：C

> 解析：胃溃疡发病年龄40～60岁、有癌变可能；十二指肠溃疡多见于青壮年、很少癌变；十二指肠溃疡好发于球部。[源:教材P380]

---

69. [A1型题｜理解] batch032_M2_A1_024

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P384

胃大部切除毕Ⅱ式吻合术后，进食后半小时出现心悸、出冷汗、乏力、腹泻，最可能的远期并发症是

- A. 碱性反流性胃炎
- B. 晚期倾倒综合征
- C. 早期倾倒综合征 ✅
- D. 残胃继发癌
- E. 吻合口梗阻

答案：C

> 解析：早期倾倒综合征于进食后半小时出现心悸、冷汗、乏力等血容量不足表现，伴恶心呕吐腹泻，因高渗胃内容物快速入肠；晚期于2～4小时、为反应性低血糖。[源:教材P384]

70. [A2型题｜应用] batch032_M2_A2_005

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P381

男性，50岁。上腹痛反复发作10年，近2个月反复呕吐，呕吐物为不含胆汁的宿食，有腐败酸臭味，伴消瘦、脱水。查体：上腹可见胃型，振水音(+)。最可能的诊断是

- A. 胃癌幽门梗阻
- B. 瘢痕性幽门梗阻 ✅
- C. 胃排空延迟
- D. 急性胰腺炎
- E. 机械性肠梗阻

答案：B

> 解析：长期溃疡史+呕吐不含胆汁宿食+胃型+振水音，符合瘢痕性幽门梗阻（幽门/球部溃疡反复发作致瘢痕狭窄）。胃癌梗阻可有呕血黑便、肿块；胃瘫多见于术后。[源:教材P381]

---

71. [A2型题｜应用] batch032_M2_A2_006

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病丨页码：教材P376

男性，58岁。上腹隐痛伴食欲不振、消瘦2个月，黑便1周。既往无胃病史。首选的诊断方法是

- A. X线钡餐检查
- B. 电子胃镜检查 ✅
- C. CT检查
- D. 肿瘤标志物CEA
- E. 超声内镜

答案：B

> 解析：40岁以上、无胃病史出现上消化道症状伴消瘦黑便属胃癌高危，电子胃镜可直接观察并活检，是诊断胃癌最有效方法。[源:教材P376]

---

72. [B1型题｜理解] batch032_M2_B1_003

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P380

胃溃疡急性穿孔最常见的部位是

- A. 胃小弯 ✅
- B. 球部前壁
- C. 球部后壁
- D. 胃窦部
- E. 贲门部

答案：A

> 解析：胃溃疡穿孔多见于胃小弯；十二指肠溃疡穿孔多发生在球部前壁。[源:教材P380]

---

73. [B1型题｜理解] batch032_M2_B1_004

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P380

十二指肠溃疡急性穿孔最常见的部位是

- A. 胃小弯
- B. 球部前壁 ✅
- C. 球部后壁
- D. 胃窦部
- E. 贲门部

答案：B

> 解析：十二指肠溃疡穿孔多发生在球部前壁；后壁溃疡穿孔可局部粘连包裹形成慢性穿透性溃疡。[源:教材P380]

---

74. [X型题｜应用] batch032_M2_X_007

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P383

需要外科手术治疗的胃十二指肠溃疡并发症包括

- A. 急性穿孔 ✅
- B. 溃疡大出血 ✅
- C. 瘢痕性幽门梗阻 ✅
- D. 胃溃疡癌变 ✅
- E. 胃食管反流病

答案：ABCD

> 解析：外科手术仅针对溃疡并发症：急性穿孔、大出血、瘢痕性幽门梗阻、癌变（胃溃疡可能癌变，处理应积极）。胃食管反流病为独立疾病，非溃疡并发症。[源:教材P380-383]

---

75. [X型题｜分析] batch032_M2_X_008

> 模块：腹外疝、急性化脓性腹膜炎、胃十二指肠疾病｜页码：教材P374

关于胃癌的扩散与转移，正确的有

- A. 淋巴转移是主要途径 ✅
- B. 左锁上淋巴结属魏氏转移 ✅
- C. 血行转移以肝脏为多 ✅
- D. 种植卵巢称库肯伯格瘤 ✅
- E. 早期胃癌无淋巴结转移

答案：ABCD

> 解析：淋巴转移是主要途径（早期近20%、进展期70%）；左锁骨上淋巴结为胸导管转移（Virchow）；血行肝转移多见；种植至卵巢为Krukenberg瘤。早期胃癌也可有淋巴转移（近20%），故E错。[源:教材P374]

小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病（40题）

76. [A1型题｜应用] batch032_M3_A1_001

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病｜页码：教材P395

患者，女，34岁。阵发性腹痛伴呕吐3天，腹胀并停止排气排便2天，1天来腹痛加剧并转为持续性，2年前因阑尾穿孔行阑尾切除术。查体：右侧腹部稍膨隆，右下腹有明显压痛、轻度肌紧张，肠鸣音减弱，偶闻气过水声。最可能的诊断是

- A. 阑尾残株炎
- B. 粘连性不全性肠梗阻
- C. 麻痹性肠梗阻
- D. 内疝致绞窄性肠梗阻 ✅
- E. 乙状结肠扭转

答案：D

> 解析：患者有痛、吐、胀、闭典型表现，应考虑急性完全性肠梗阻；有腹部手术史，粘连性肠梗阻可能性大。腹痛由阵发性转为持续性、腹胀不对称、右下腹固定压痛、肠鸣音减弱提示内疝所致绞窄性肠梗阻。粘连性不全性肠梗阻常可少量排气排便；麻痹性肠梗阻肠鸣音消失；阑尾残株炎表现类似阑尾炎。[源:考研真题 GS-2008-086]

---

77. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_002

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P394

下列不属于绞窄性肠梗阻典型临床表现的是

- A. 早期休克
- B. 腹胀 ✅
- C. 腹部压痛
- D. 血性腹泻
- E. 持续腹痛

答案：B

> 解析：急性肠梗阻早期出现休克、腹膜炎体征、血便均提示肠管血运障碍，应考虑绞窄性肠梗阻。腹胀见于低位肠梗阻，并非绞窄性肠梗阻的特有表现，故答B。[源:考研真题 GS-2021-064]

---

78. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_003

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P393

肠梗阻病人不宜使用的吸入麻醉药是

- A. 七氟烷
- B. 恩氟烷
- C. 异氟烷
- D. 氧化亚氮 ✅
- E. 地氟烷

答案：D

> 解析：氧化亚氮（N2O）吸入后可使体内封闭腔（如肠腔、中耳等）内压升高，肠梗阻病人肠腔为闭袢，使用后可致肠腔压力进一步升高，故禁用于肠梗阻病人。恩氟烷、异氟烷、七氟烷肠梗阻病人均可使用。[源:考研真题 GS-2013-084]

---

79. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_004

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P395

临床上最常见的粘连性肠梗阻的病因为

- A. 腹腔内炎症
- B. 腹腔内出血
- C. 先天发育异常
- D. 腹部手术后 ✅
- E. 腹部创伤

答案：D

> 解析：粘连性肠梗阻是肠梗阻最常见类型（约占40%～60%）；肠粘连分先天性与后天性，后天性多由腹腔内手术、炎症、创伤、出血、异物引起，临床上以手术后所致的粘连性肠梗阻最常见。[源:教材P395]

---

80. [A1型题｜应用] batch032_M3_A1_005

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P393

一位肠梗阻患者，恶心、呕吐、少尿、尿比重增高，眼窝凹陷，肢端湿冷，血压偏低，血清Na+正常。首选的补液种类是

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 生理盐水
- C. 平衡盐溶液 ✅
- D. 5%氯化钠溶液
- E. 羟乙基淀粉

答案：C

> 解析：肠梗阻患者眼窝凹陷、肢端湿冷、血压偏低、血钠正常，为等渗性缺水。等渗性缺水补液首选平衡盐溶液，其电解质含量与血浆相仿。5%葡萄糖为能量液不含电解质；生理盐水Cl-偏高易致高氯性酸中毒；5%氯化钠用于低渗性缺水。[源:考研真题 GS-2009-078]

---

81. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_006

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P389

肠结核病变主要发生在

- A. 回盲部 ✅
- B. 空肠上段
- C. 横结肠
- D. 乙状结肠
- E. 直肠

答案：A

> 解析：结核分枝杆菌主要累及肠壁淋巴组织，肠结核病变主要发生在回盲部及末端回肠，病理形态表现为溃疡型和增生型。参阅教材P389。

---

82. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_007

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P389

肠结核X线钡剂造影的特征性表现是

- A. 龛影
- B. 铅管征
- C. 鸟嘴征
- D. 杯口征
- E. 跳跃征 ✅

答案：E

> 解析：肠结核X线钡剂造影可显示病变肠壁充盈不完全或不充盈的“跳跃征”（Stierlin征）。铅管征见于溃疡性结肠炎；鸟嘴征见于乙状结肠扭转；杯口征见于肠套叠。参阅教材P389。

---

83. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_008

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P391

克罗恩病内镜下的特征性黏膜表现是

- A. 鹅卵石样改变 ✅
- B. 地图状溃疡
- C. 环行溃疡
- D. 火山口样溃疡
- E. 弥漫性糜烂

答案：A

> 解析：克罗恩病炎症波及肠壁全层，病变黏膜增厚，可见裂隙状深溃疡，黏膜水肿突出表面呈鹅卵石样改变。参阅教材P391。

---

84. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_009

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P391

克罗恩病手术处理病变肠段时，推荐切除范围是

- A. 距病变2cm ✅
- B. 距病变10cm
- C. 仅切肉眼病变
- D. 一律广泛切除
- E. 仅行短路吻合

答案：A

> 解析：克罗恩病手术应切除病变部位包括近、远侧肉眼观正常肠管2cm，肠管吻合推荐侧侧吻合，以减少术后复发。广泛切除可导致短肠综合征，应避免。参阅教材P391。

---

85. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_010

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P395

临床上最常见的肠梗阻类型是

- A. 粘连性肠梗阻 ✅
- B. 肠扭转
- C. 肠套叠
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 血运性肠梗阻

答案：A

> 解析：粘连性肠梗阻是肠梗阻最常见的一种类型，发生率约占肠梗阻的40%～60%，临床上以手术后所致的粘连性肠梗阻最常见。参阅教材P395。

---

86. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_011

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P394

提示肠梗阻可能为绞窄性的依据是

- A. 腹痛间歇期长
- B. 腹胀均匀对称
- C. 肠鸣音亢进
- D. 肛门大量排气
- E. 早期休克难纠正 ✅

答案：E

> 解析：有下列表现应考虑绞窄性肠梗阻：腹痛初始即持续性剧烈；病情发展快、早期出现休克且抗休克改善不明显；有腹膜炎体征；腹胀不对称、局部隆起；呕吐早而频繁、血性液；X线见孤立扩大肠袢；非手术治疗无改善。B、C、D、A为单纯性肠梗阻或一般表现。参阅教材P394。

---

87. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_012

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P396

肠扭转的好发部位是

- A. 十二指肠空肠曲
- B. 盲肠和升结肠
- C. 横结肠和降结肠
- D. 直肠和肛管
- E. 小肠和乙状结肠 ✅

答案：E

> 解析：肠扭转是一段肠袢及其系膜沿系膜长轴扭转造成的闭袢性肠梗阻，既有梗阻又有血运障碍。好发部位是小肠和乙状结肠。参阅教材P396。

---

88. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_013

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P397

小儿肠套叠的三大典型症状是

- A. 便血、贫血、腹部包块
- B. 腹痛、发热、黄疸
- C. 呕吐、腹泻、脱水
- D. 腹胀、便秘、消瘦
- E. 腹痛、血便、腹部肿块 ✅

答案：E

> 解析：肠套叠三大典型症状是腹痛、血便和腹部肿块，表现为突然发作剧烈阵发性腹痛、果酱样血便，腹部扪及腊肠形压痛性肿块。参阅教材P397。

---

89. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_014

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P397

有关空气灌肠复位治疗的叙述，正确的是

- A. 适用于回盲型或结肠型套叠早期 ✅
- B. 适用于病期超过48小时者
- C. 疑有肠坏死仍可加压注气
- D. 压力先用80mmHg再升至60mmHg
- E. 注气压力最高可达120mmHg

答案：A

> 解析：空气或钡剂灌肠既是诊断也是有效治疗，适用于回盲型或结肠型套叠早期。一般空气压力先用60mmHg，明确后继续注气加压至80mmHg左右。病期超过48小时、疑有肠坏死、复位后腹膜炎者均应手术。参阅教材P397。

---

90. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_015

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P399

发生短肠综合征的严重残存小肠长度（保留结肠时）约为

- A. 少于75cm ✅
- B. 少于150cm

- C. 少于200cm
- D. 少于50cm
- E. 少于100cm

答案：A

> 解析：切除小肠达50%～70%可引起吸收不良；残存小肠少于75cm（有完整结肠），或丧失回盲瓣、残存小肠少于100cm，可产生严重症状导致短肠综合征。参阅教材P399。

---

91. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_016

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P402

阑尾动脉的解剖特点是

- A. 发自直肠上动脉
- B. 肠系膜上动脉分支
- C. 有丰富侧支吻合
- D. 回结肠动脉终末支 ✅
- E. 与阑尾静脉伴行

答案：D

> 解析：阑尾动脉系回结肠动脉的分支，是一种无侧支的终末动脉，血运障碍时易导致阑尾坏死。阑尾静脉与动脉伴行，回流入门静脉，炎症时菌栓脱落可引起门静脉炎。参阅教材P402。

---

92. [A1型题｜记忆] batch032_M3_A1_017

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P403

急性阑尾炎最常见的病因是阑尾管腔阻塞，其中最常见阻塞原因是

- A. 淋巴滤泡增生 ✅
- B. 粪石阻塞
- C. 异物阻塞
- D. 蛔虫阻塞
- E. 肿瘤阻塞

答案：A

> 解析：阑尾管腔阻塞是急性阑尾炎最常见病因。阻塞最常见原因是淋巴滤泡明显增生，约占60%（多见于年轻人）；肠石约占35%；异物、炎性狭窄、食物残渣、蛔虫、肿瘤等较少见。参阅教材P403。

---

93. [A1型题｜应用] batch032_M3_A1_018

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P404

急性阑尾炎典型的转移性腹痛是指

- A. 脐周→左上腹
- B. 右下腹→全腹
- C. 上腹→脐周→右下腹 ✅
- D. 腰部→右下腹
- E. 耻骨上→盆腔

答案：C

> 解析：典型腹痛始于上腹，逐渐移向脐部，数小时（6～8小时）后转移并局限在右下腹，约70%～80%病人有此特点。盲肠后位痛在腰部，盆位在耻骨上区，为特殊位置表现。参阅教材P404。

---

94. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_019

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P404

急性阑尾炎最重要、最有诊断价值的体征是

- A. 结肠充气征
- B. 右下腹反跳痛
- C. 右下腹肌紧张
- D. 肠鸣音减弱
- E. 右下腹固定压痛 ✅

答案：E

> 解析：右下腹固定压痛是急性阑尾炎最常见的重要体征，也是最有诊断价值的体征，压痛点常位于麦氏点，可随阑尾位置变异而改变，但始终固定。反跳痛、肌紧张提示化脓坏疽或穿孔。参阅教材P404。

---

95. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_020

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P420

关于左、右半结肠癌临床表现差异的叙述，正确的是

- A. 左半易出现坏死出血感染
- B. 左半以腹痛、肿块为主
- C. 右半易引起肠腔狭窄梗阻
- D. 右半以腹痛、肿块、全身表现为主 ✅
- E. 两者分子生物学差异小

答案：D

> 解析：右半结肠肠腔大、以隆起型多见，易坏死出血感染，以腹痛、腹部肿块和全身症状（贫血、消瘦、乏力）为主；左半结肠肠腔小、以浸润型多见，易引起肠腔狭窄梗阻，以梗阻症状及排便习惯改变为主。两者分子生物学差异大。参阅教材P420。

---

96. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_021

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P422

上段直肠癌最主要的淋巴引流方向是

- A. 至锁骨上淋巴结
- B. 向下至腹股沟淋巴结
- C. 向侧方至髂内淋巴结
- D. 经血行至肺
- E. 向上至肠系膜下动脉旁 ✅

答案：E

> 解析：齿状线以上淋巴向上沿直肠上动脉到肠系膜下动脉旁淋巴结，是直肠最主要淋巴引流途径；向两侧至髂内淋巴结；向下至坐骨直肠窝。下段直肠癌以向上和侧方转移为主；齿状线以下向下至腹股沟。参阅教材P422。

---

97. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_022

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P435

内痔的好发部位是

- A. 截石位3、7、11点 ✅
- B. 截石位6、12点
- C. 膝胸位3、7、11点
- D. 肛门后正中线
- E. 齿状线任意处

答案：A

> 解析：内痔好发部位为截石位3点、7点、11点位（对应直肠上静脉丛分支处）。膝胸位与截石位时钟记录相反。参阅教材P435。

---

98. [A1型题｜理解] batch032_M3_A1_023

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P435

内痔分度中，痔脱出不能还纳或还纳后又脱出，伴出血，属于

- A. Ⅲ度
- B. Ⅰ度
- C. Ⅱ度
- D. Ⅳ度 ✅
- E. 混合痔

答案：D

> 解析：内痔分度：Ⅰ度便时带血无脱出；Ⅱ度排便时脱出便后自行还纳；Ⅲ度需手辅助还纳；Ⅳ度痔脱出不能还纳或还纳后又脱出，可伴出血。参阅教材P435。

99. [A2型题｜应用] batch032_M3_A2_001

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P395

男性，45岁。阵发性腹痛、呕吐、腹胀、停止排气排便3天。既往2年前因阑尾化脓穿孔行阑尾切除术。查体：腹膨隆，可见肠型，右下腹轻压痛，肠鸣音亢进，偶闻气过水声。X线示多个液气平面。最可能的诊断是

- A. 粘连性肠梗阻 ✅
- B. 绞窄性肠梗阻
- C. 结肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 肠系膜血管栓塞

答案：A

> 解析：患者有痛、吐、胀、闭四大症状及肠型、气过水声，符合机械性肠梗阻；既往阑尾手术史，故粘连性肠梗阻可能性大。无持续性剧痛、休克、腹膜炎等绞窄征象，不支持绞窄性；肠鸣音亢进不支持麻痹性。参阅教材P395。

---

100. [A2型题｜应用] batch032_M3_A2_002

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P404

女性，26岁。转移性右下腹痛18小时，伴恶心、呕吐、发热38℃。查体：麦氏点固定压痛、反跳痛及肌紧张。白细胞计数14×10^9/L。最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎 ✅
- B. 右侧输尿管结石
- C. 胃十二指肠溃疡穿孔
- D. 异位妊娠破裂
- E. 急性胆囊炎

答案：A

> 解析：转移性右下腹痛、麦氏点固定压痛伴反跳痛肌紧张、发热及白细胞升高，符合急性阑尾炎。右侧输尿管结石无右下腹固定压痛；溃疡穿孔有板状腹及膈下游离气体；异位妊娠有停经史及腹腔内出血。参阅教材P404。

101. [A2型题｜应用] batch032_M3_A2_003

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P420

男性，60岁。贫血、消瘦、乏力伴右下腹隐痛2个月，排便次数增多、偶有黏液血便。查体：右中腹触及质硬肿块，活动度差。最可能的诊断是

- A. 阑尾周围脓肿
- B. 克罗恩病
- C. 肠结核
- D. 右半结肠癌 ✅
- E. 溃疡性结肠炎

答案：D

> 解析：老年男性，贫血消瘦乏力、右腹肿块、排便习惯改变及黏液血便，符合右半结肠癌表现（右半结肠腔大、隆起型多见，以腹痛、肿块、全身表现为主）。需结肠镜活检明确。参阅教材P420。

---

102. [A2型题｜应用] batch032_M3_A2_004

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P422

男性，55岁。便血伴大便变细、排便不尽感3个月。直肠指诊：距肛缘6cm触及质硬菜花样肿物，指套染血。最可能的诊断是

- A. 肛裂
- B. 内痔
- C. 直肠息肉
- D. 直肠癌 ✅
- E. 直肠脱垂

答案：D

> 解析：便血、便细、排便不尽感，直肠指诊触及质硬菜花样肿物且指套染血，符合直肠癌（低位直肠癌多可触及）。内痔为柔软痔核、无质硬肿块；息肉圆形有蒂可活动；肛裂有周期性痛。参阅教材P422。

103. [A2型题｜应用] batch032_M3_A2_005

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P431

男性，32岁。肛周右侧持续性跳痛、红肿2天，行走及排便时加重，无明显发热。查体：右后方可触及肿物，红肿、压痛明显，有波动感。最可能的诊断是

- A. 肛门周围脓肿 ✅
- B. 坐骨直肠窝脓肿
- C. 血栓性外痔
- D. 肛瘘继发感染
- E. 肛裂并前哨痔

答案：A

> 解析：肛周皮下脓肿最常见，位于肛门后方或侧方皮下，局部持续性跳痛、红肿、压痛、波动感，全身症状不明显。坐骨直肠窝脓肿范围大、全身中毒症状重；肛瘘有外口溢脓；血栓性外痔为暗紫色肿物。参阅教材P431。

---

104. [B1型题｜记忆] batch032_M3_B1_001

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P421

老年人结肠梗阻最常见的病因是：

- A. 结肠癌 ✅
- B. 肠套叠
- C. 乙状结肠冗长
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 粪块堵塞

答案：A

> 解析：老年人结肠梗阻最常见的病因是结肠癌及粪块堵塞。2岁以内小儿肠梗阻多为肠套叠；粘连性肠梗阻是临床上最常见的肠梗阻（但非老年人结肠梗阻最常见病因）；乙状结肠冗长临床少见。[源:考研真题 GS-2023-132]

---

105. [B1型题｜理解] batch032_M3_B1_002

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P423

适用于肛管外括约肌或肛提肌受累，需行永久性乙状结肠单腔造口的直肠癌根治术是：

- A. Miles手术 ✅
- B. Dixon手术
- C. Hartmann手术
- D. 局部切除术
- E. 乙状结肠双腔造口

答案：A

> 解析：Miles（腹会阴切除术）同时经腹会阴切除全部直肠、肛提肌、坐骨直肠窝脂肪及肛门括约肌，于左下腹行永久性乙状结肠单腔造口，适用于肛管外括约肌或肛提肌受累及术前肛门失禁者。参阅教材P423。

---

106. [B1型题｜理解] batch032_M3_B1_003

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P424

2：肿瘤远端切缘至少2cm，保留肛门括约肌、一期吻合恢复肠管连续性的直肠癌保肛手术是：

- A. Miles手术
- B. Dixon手术 ✅
- C. Hartmann手术
- D. 局部切除术
- E. 乙状结肠双腔造口

答案：B

> 解析：Dixon（低位前切除术）切除肿瘤后一期吻合、恢复肠管连续性，是应用最多的直肠癌保肛手术，要求肿瘤远端切缘至少2cm（低位直肠癌至少1cm），适用于肛管外括约肌和肛提肌未受累者。参阅教材P424。

---

107. [B1型题｜理解] batch032_M3_B1_004

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P424

3：适用于一般情况很差、不能耐受Miles或急性梗阻不宜行Dixon，切除肿瘤后近端结肠造口、远端残腔封闭的手术是：

- A. Miles手术
- B. Dixon手术
- C. Hartmann手术 ✅
- D. 局部切除术
- E. 乙状结肠双腔造口

答案：C

> 解析：Hartmann手术（经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭）适用于一般情况差不能耐受Miles或急性梗阻不宜行Dixon的病人。乙状结肠双腔造口多用于晚期姑息解除梗阻。参阅教材P424。

---

108. [X型题｜记忆] batch032_M3_X_001

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P393

肠梗阻的共同临床表现包括

- A. 阵发性腹痛 ✅
- B. 恶心呕吐 ✅
- C. 进行性腹胀 ✅
- D. 停止排气排便 ✅
- E. 腹膜刺激征

答案：ABCD

> 解析：肠梗阻共同表现为腹痛、呕吐、腹胀及停止自肛门排气排便（痛、吐、胀、闭）。腹痛为阵发性绞痛（机械性）；腹膜刺激征仅见于绞窄性或腹膜炎，非所有肠梗阻共有。参阅教材P393。

---

109. [X型题｜分析] batch032_M3_X_002

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P394

下列表现中，支持诊断为绞窄性肠梗阻的有

- A. 早期出现休克且抗休克效果差 ✅
- B. 腹胀不对称、触及压痛肿块 ✅
- C. 呕吐物、引流液为血性 ✅
- D. 腹部X线见孤立扩大肠袢 ✅
- E. 肠鸣音亢进、金属音

答案：ABCD

> 解析：绞窄性肠梗阻依据：早期休克且抗休克改善不明显；腹膜炎体征；腹胀不对称、局部隆起或压痛肿块；呕吐早而频繁、血性液，腹腔穿刺抽出血性液；X线见孤立扩大肠袢；非手术治疗无改善。肠鸣音亢进、金属音为单纯机械性肠梗阻表现，绞窄时肠鸣音减弱或消失。参阅教材P394。

---

110. [X型题｜记忆] batch032_M3_X_003

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P407

急性阑尾炎未经及时治疗可发生的并发症包括

- A. 腹腔脓肿 ✅
- B. 内瘘形成 ✅
- C. 外瘘形成 ✅
- D. 化脓性门静脉炎 ✅
- E. 切口感染

答案：ABCD

> 解析：急性阑尾炎并发症：腹腔脓肿（最常见阑尾周围脓肿）、内瘘或外瘘形成、化脓性门静脉炎。切口感染为阑尾切除术后并发症，而非急性阑尾炎本身并发症。参阅教材P407。

---

111. [X型题 | 记忆] batch032_M3_X_004

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病 | 页码：教材P408

阑尾切除术后常见的并发症包括

- A. 腹腔内出血 ✅
- B. 手术切口感染 ✅
- C. 粘连性肠梗阻 ✅
- D. 阑尾残株炎 ✅
- E. 化脓性门静脉炎

答案：ABCD

> 解析：阑尾切除术后并发症：出血、切口感染（最常见）、粘连性肠梗阻、阑尾残株炎、粪瘘。化脓性门静脉炎是急性阑尾炎（未手术）的并发症，非术后。参阅教材P408。

---

112. [X型题 | 记忆] batch032_M3_X_005

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病 | 页码：教材P419

结肠癌根据肿瘤大体形态可分为

- A. 隆起型 ✅
- B. 浸润型 ✅
- C. 溃疡型 ✅
- D. 胶样型
- E. 缩窄型

答案：ABC

> 解析：结肠癌大体形态分隆起型（好发于右半结肠）、浸润型（多发生于左半结肠，易致狭窄梗阻）、溃疡型（常见，向深层生长浸润）三型。胶样型、缩窄型非教材标准大体分型。参阅教材P419。

---

113. [X型题｜应用] batch032_M3_X_006

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P422

直肠癌的主要扩散与转移途径包括

- A. 直接浸润肠壁深层 ✅
- B. 淋巴转移 ✅
- C. 血行转移至肝 ✅
- D. 种植转移 ✅
- E. 沿神经鞘逆行

答案：ABCD

> 解析：直肠癌扩散转移：直接浸润（沿肠壁纵轴浸润较晚，约1.5～2年浸润一圈）；淋巴转移为主要途径（上段向上沿直肠上动脉）；血行转移经门静脉至肝，亦可至肺骨脑；种植转移机会较小。神经蔓延非主要途径。参阅教材P422。

---

114. [X型题｜记忆] batch032_M3_X_007

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病丨页码：教材P429

肛裂“三联征”的组成包括

- A. 肛门裂 ✅
- B. 前哨痔 ✅
- C. 肛乳头肥大 ✅
- D. 内痔出血
- E. 肛瘘流脓

答案：ABC

> 解析：慢性肛裂上端肛瓣和肛乳头水肿形成肛乳头肥大，下端形成袋状皮垂即前哨痔；因裂口、前哨痔、肛乳头肥大常同时存在，称肛裂“三联征”，是肛裂典型表现。内痔、肛瘘不属三联征。参阅教材P429。

---

115. [X型题 | 分析] batch032_M3_X_008

> 模块：小肠疾病、阑尾疾病、结直肠与肛管疾病 | 页码：教材P435

关于痔的治疗原则，正确的叙述有

- A. 无症状的痔无需治疗 ✅
- B. 注射疗法适于Ⅰ、Ⅱ度出血性内痔 ✅
- C. 胶圈套扎适于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度内痔 ✅
- D. 痔切除术适于Ⅱ～Ⅳ度内痔和混合痔 ✅
- E. 所有内痔均应首选痔切除术

答案：ABCD

> 解析：痔治疗原则：无症状痔无需治疗；有症状者重在消除症状而非根治，以非手术为主。注射疗法治Ⅰ、Ⅱ度出血性内痔；胶圈套扎治Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度内痔；痔切除术用于Ⅱ～Ⅳ度内痔和混合痔。手术只限于非手术失败或重度痔，并非所有内痔首选手术。参阅教材P435。

肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病（42题）

116. [A1型题 | 记忆] batch032_M4_A1_001

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P443

关于肝小叶基本结构的描述，正确的是

- A. 周边为肝静脉
- B. 中央为门静脉
- C. 周边为中央静脉
- D. 中央为肝动脉
- E. 中央为中央静脉 ✅

答案：E

> 解析：肝小叶中央是中央静脉，肝细胞索围绕其放射状排列；门静脉与肝动脉小分支血流汇合于肝窦；Kupffer细胞附着于肝窦壁；胆小管由相邻肝细胞胞膜凹陷形成。参阅教材P443。

---

117. [A1型题｜记忆] batch032_M4_A1_002

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P444

正常肝组织可耐受切除而不影响生理功能的肝实质比例约为

- A. 50%～60%
- B. 60%～70%
- C. 70%～80% ✅
- D. 80%～90%
- E. 90%以上

答案：C

> 解析：研究证明，切除正常肝实质的70%～80%仍可维持正常生理功能，且能再生至接近原肝重量，故局限性病变可施行肝段乃至更大范围切除。参阅教材P444。

---

118. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_003

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P445

细菌性肝脓肿最主要的细菌侵入途径是

- A. 淋巴系统扩散
- B. 门静脉播散
- C. 肝动脉播散
- D. 胆道逆行上行 ✅
- E. 开放性损伤直接侵入

答案：D

> 解析：良性或恶性病变导致胆道梗阻并发生化脓性胆管炎时，细菌沿胆管上行，是引起细菌性肝脓肿的主要原因。参阅教材P445。

---

119. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_004

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P445

下列细菌中，较少作为细菌性肝脓肿常见致病菌的是

- A. 肺炎克雷伯菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 厌氧链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 伤寒杆菌 ✅

答案：E

> 解析：细菌性肝脓肿致病菌多为肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、厌氧链球菌、葡萄球菌等；伤寒杆菌并非其常见致病菌。参阅教材P445。

---

120. [A1型题 | 理解] batch032_M4_A1_005

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P446

关于细菌性肝脓肿与阿米巴肝脓肿的鉴别，正确的是

- A. 细菌性多见于20～40岁
- B. 阿米巴多见于50岁以上
- C. 阿米巴脓液多为黄白色
- D. 阿米巴多继发于胆道感染
- E. 阿米巴多继发于阿米巴痢疾 ✅

答案：E

> 解析：阿米巴肝脓肿多源于肠道阿米巴感染，绝大多数单发，继发于阿米巴痢疾后，少见糖尿病史；细菌性多继发于胆道感染，年龄多>50岁，脓液黄白色。参阅教材P446。

---

121. [A1型题 | 记忆] batch032_M4_A1_006

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P447

棘球蚴病（包虫病）最常累及的器官是

- A. 肾脏

- B. 肺脏
- C. 脑
- D. 肝脏 ✅
- E. 脾脏

答案：D

> 解析：肝包虫病临床上最常见，约占75%，其次为肺包虫病约占15%。参阅教材P447。

---

122. [A1型题 | 记忆] batch032_M4_A1_007

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P448

根据中华医学会外科学分会分类，直径≤1cm的肝癌称为

- A. 微小肝癌 ✅
- B. 小肝癌
- C. 大肝癌
- D. 巨大肝癌
- E. 弥漫型肝癌

答案：A

> 解析：分类为微小肝癌（直径≤1cm）、小肝癌（>1cm且≤5cm）、大肝癌（>5cm且≤10cm）、巨大肝癌（>10cm）。参阅教材P448。

---

123. [A1型题 | 记忆] batch032_M4_A1_008

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P448

临床诊断原发性肝细胞癌时，甲胎蛋白（AFP）的诊断参考值通常要求

- A. ≥40ng/ml
- B. ≥100ng/ml
- C. ≥200ng/ml
- D. ≥400ng/ml ✅
- E. ≥800ng/ml

答案：D

> 解析：有肝炎或肝硬化病史，AFP≥400ng/ml，且超声/CT/MRI发现肝实质性肿块并具有典型影像学表现者，可作出临床诊断。参阅教材P448。

---

124. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_009

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P449

肝癌切除后总体5年生存率约为30%～40%，其中微小肝癌和小肝癌切除后5年生存率可达

- A. 40%以上
- B. 50%以上
- C. 60%以上
- D. 75%以上 ✅
- E. 90%以上

答案：D

> 解析：肝癌切除后总体5年生存率为30%～40%，微小肝癌和小肝癌切除后5年生存率可达75%以上。参阅教材P449。

---

125. [A1型题｜应用] batch032_M4_A1_010

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P451

关于先天性肝囊肿的处理原则，正确的是

- A. 所有囊肿均需手术切除
- B. 囊肿伴感染禁忌引流
- C. 囊肿均须穿刺引流
- D. 多发性囊肿一律肝切除
- E. 无症状小囊肿可定期观察 ✅

答案：E

> 解析：无症状的肝囊肿一般不需特殊处理；巨大且伴症状者可行穿刺引流或腹腔镜开窗术；伴感染、囊内出血者可穿刺引流或开窗术后置管。参阅教材P451。

---

126. [A1型题 | 记忆] batch032_M4_A1_011

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P452

门静脉系统区别于体静脉的两大解剖特点是

- A. 直接回流入右心房
- B. 位于两毛细血管网之间且有瓣膜
- C. 有丰富瓣膜且压力高
- D. 位于两毛细血管网之间且无瓣膜 ✅
- E. 与肝动脉无交通

答案：D

> 解析：门静脉系统位于两个毛细血管网之间，且门静脉系统内没有瓣膜，是其区别于体静脉的两大特点。参阅教材P452。

---

127. [A1型题 | 理解] batch032_M4_A1_012

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P453

门静脉同腔静脉系统之间的侧支交通，不包括下列哪一途径

- A. 胃底、食管下段静脉交通支
- B. 直肠下端、肛管交通支
- C. 前腹壁交通支
- D. 腹膜后交通支
- E. 脾静脉与左肾静脉交通支 ✅

答案：E

> 解析：门静脉与腔静脉间有四个交通支：胃底食管下段、直肠下端肛管、前腹壁、腹膜后（Retzius静脉丛）。脾肾静脉交通支属于门体分流手术方式而非解剖交通支。参阅教材P453。

128. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_013

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病丨页码：教材P454

门静脉高压时四个交通支中最具临床意义、受压力差影响最早最显著的是

- A. 胃底、食管下段交通支 ✅
- B. 直肠下端、肛管交通支
- C. 前腹壁交通支
- D. 腹膜后交通支
- E. 肠系膜上、下静脉间交通支

答案：A

> 解析：食管胃底交通支离门静脉主干和腔静脉最近，压力差最大，受门静脉高压影响最早、最显著，曲张静脉破裂可致致命性大出血。参阅教材P454。

---

129. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_014

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病丨页码：教材P455

Child-Pugh肝功能分级所依据的指标不包括

- A. 血清胆红素
- B. 血浆白蛋白
- C. 凝血酶原延长时间
- D. 腹水与肝性脑病
- E. 门静脉内径 ✅

答案：E

> 解析：Child-Pugh分级项目为血清胆红素、血浆白蛋白、凝血酶原延长时间、腹水、肝性脑病；门静脉内径为影像学测量指标，不计入分级。参阅教材P455。

---

130. [A1型题｜记忆] batch032_M4_A1_015

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P455

门静脉高压症时，门静脉主干内径常达到

- A. ≥0.8cm
- B. ≥1.0cm
- C. ≥1.3cm ✅
- D. ≥1.5cm
- E. ≥2.0cm

答案：C

> 解析：门静脉高压症时门静脉内径常≥1.3cm，脾静脉内径常≥0.8cm。参阅教材P455。

---

131. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_016

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P456

经颈静脉肝内门体静脉分流术（TIPS）置入肝内支撑管的内径通常为

- A. 4～6mm
- B. 8～12mm ✅
- C. 14～16mm
- D. 18～20mm
- E. 22～24mm

答案：B

> 解析：TIPS经颈静脉在肝静脉与门静脉主要分支间建立通道并置入支架，内支撑管直径为8～12mm，可明显降低门静脉压力。参阅教材P456。

---

132. [A1型题｜记忆] batch032_M4_A1_017

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P457

在我国门静脉高压症外科治疗中应用最广泛的断流手术是

- A. 贲门周围血管离断术 ✅
- B. 食管下端横断术
- C. 胃底横断术
- D. 胃周围血管缝扎术
- E. 食管下端胃底切除术

答案：A

> 解析：脾切除加贲门周围血管离断术最为常用，可较彻底阻断门-奇静脉间反常血流，又保存门静脉入肝血流；国内临床应用最广（约85%）。参阅教材P457。

---

133. [A1型题 | 应用] batch032_M4_A1_018

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P457

门静脉高压症各类分流术中，术后肝性脑病发生率最高的是

- A. 远端脾-肾静脉分流术
- B. 限制性门-腔静脉分流术
- C. 非选择性门体分流术 ✅
- D. 选择性门体分流术
- E. 肠系膜上-下腔静脉桥式分流

答案：C

> 解析：非选择性门体分流术将入肝门静脉血完全转流入体循环，肝性脑病发生率高达30%～50%，易引起肝衰竭；选择性分流肝性脑病发生率低。参阅教材P457。

---

134. [A1型题 | 理解] batch032_M4_A1_019

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P458

巴德-吉亚利综合征（布-加综合征）的主要病变基础是

- A. 肠系膜上静脉栓塞
- B. 门静脉主干血栓形成
- C. 脾静脉主干闭塞

- D. 肝静脉或肝上段下腔静脉阻塞 ✅
- E. 奇静脉回流受阻

答案：D

> 解析：巴德-吉亚利综合征由先天或后天因素引起肝静脉和/或其开口以上的下腔静脉阻塞，以门静脉高压或门腔静脉高压为特征。参阅教材P458。

---

135. [A1型题 | 理解] batch032_M4_A1_020

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P461

胆囊三角（Calot三角）内常穿过、胆道手术需特别注意避免损伤的结构是

- A. 胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管 ✅
- B. 门静脉主干及其属支
- C. 胆囊管与肝总管交界处
- D. 胆总管十二指肠部
- E. 胃十二指肠上动脉

答案：A

> 解析：胆囊三角由胆囊管、肝总管、肝下缘构成，胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管常在此区穿过，胆道手术应特别注意避免损伤。参阅教材P461。

---

136. [A1型题 | 理解] batch032_M4_A1_021

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P462

关于胆囊生理功能的描述，正确的是

- A. 容积30～60ml浓缩5～10倍 ✅
- B. 容积100～150ml不浓缩
- C. 每日泌胆汁800～1200ml
- D. 仅储存不浓缩胆汁
- E. 进食后排空不受影响

答案：A

> 解析：胆囊容积仅30～60ml，但24小时能接纳约500ml胆汁，黏膜吸收水电解质可将胆汁浓缩5～10倍；进食后CCK促使胆囊收缩排空。参阅教材P462。

---

137. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_022

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P468

胆固醇类结石中，胆固醇的含量通常

- A. 超过30%
- B. 超过50%
- C. 超过70% ✅
- D. 超过90%
- E. 超过95%

答案：C

> 解析：胆固醇类结石包括混合性结石与纯胆固醇结石，其胆固醇含量超过70%，且80%以上的胆囊结石属于此类;胆色素类结石胆固醇含量低于40%。参阅教材P468。

---

138. [A1型题｜应用] batch032_M4_A1_023

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P469

胆囊结石典型胆绞痛的诱发因素，不包括

- A. 进食过饱、暴饮暴食
- B. 进食油腻食物后
- C. 睡眠中体位改变
- D. 长时间空腹平卧 ✅
- E. 胆囊收缩或结石移位

答案：D

> 解析：典型胆绞痛在饱餐、进食油腻食物后或睡眠中体位改变时发作，因胆囊收缩或结石移位嵌顿于壶腹部/颈部所致；长时间空腹平卧并非典型诱因。参阅教材P469。

---

139. [A1型题｜理解] batch032_M4_A1_024

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P470

肝外胆管结石合并胆管炎时出现的典型三联征（Charcot三联征）是指

- A. 腹痛、腹胀、黄疸
- B. 腹痛、休克、神经抑制
- C. 腹痛、黄疸、休克
- D. 寒战高热、黄疸、神经抑制
- E. 腹痛、寒战高热、黄疸 ✅

答案：E

> 解析：肝外胆管结石造成胆管梗阻并继发胆管炎时，出现Charcot三联征：腹痛、寒战高热和黄疸。参阅教材P470。

---

140. [A2型题｜应用] batch032_M4_A2_001

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P445

男性，52岁。寒战、高热2天，体温39.5℃，伴右上腹持续性胀痛、恶心。查体：右上腹压痛、肝区叩击痛，肝浊音界稍大。血常规：白细胞18×10^9/L，中性粒细胞0.88。超声示肝右叶单发液性暗区，直径约6cm。最可能的诊断是

- A. 细菌性肝脓肿 ✅
- B. 阿米巴肝脓肿
- C. 原发性肝癌
- D. 胆囊结石伴胆囊炎
- E. 右膈下脓肿

答案：A

> 解析：寒战高热、肝区痛、肝大，白细胞及中性粒明显升高，超声示肝内液性暗区，符合细菌性肝脓肿；阿米巴者年龄较轻、脓液棕褐、血培养阴性。参阅教材P445。

---

141. [A2型题｜应用] batch032_M4_A2_002

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病丨页码：教材P456

男性，48岁。乙肝肝硬化病史10年。突发呕鲜红色血约800ml，查体：面色苍白，心率110次/分，血压90/60mmHg，腹壁见迂曲扩张静脉，脾肋下3cm。胃镜示食管胃底静脉破裂出血。该情况紧急处理首选

- A. 急诊门体分流（降低静脉压）
- B. 立即行脾切除术
- C. 内镜下曲张静脉套扎 ✅
- D. 急诊原位肝移植
- E. 开腹断流（离断曲张静脉）

答案：C

> 解析：食管胃底曲张静脉破裂出血，药物治疗无效时内镜下套扎术（EVL）是控制急性出血的首选方法，与药物联合成功率可达80%～100%；急诊手术病死率高，多用于严格治疗无效者。参阅教材P456。

---

142. [A2型题｜应用] batch032_M4_A2_003

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病丨页码：教材P473

女性，45岁。饱餐后突发右上腹阵发性绞痛，向右肩放射，伴恶心呕吐、轻度发热。查体：右上腹压痛，Murphy征阳性，未触及明显包块。超声示胆囊增大、壁厚（>4mm），腔内强回声伴声影。最可能的诊断是

- A. 急性结石性胆囊炎 ✅
- B. 急性胆管炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 胆囊息肉样病变

答案：A

> 解析：饱餐油腻后右上腹痛、Murphy征阳性，超声见胆囊结石及胆囊壁增厚（>4mm）“双边征”，符合急性结石性胆囊炎；胆管炎应有黄疸及Charcot三联征。参阅教材P473。

---

143. [A2型题 | 分析] batch032_M4_A2_004

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P475

男性，60岁。反复右上腹痛、寒战高热1周，今日出现神志淡漠、血压下降。查体：T39.8℃，P120次/分，BP85/50mmHg，皮肤巩膜黄染，剑突下压痛、轻度肌紧张。既往有胆管结石病史。最可能的诊断是

- A. 急性胆管炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 梗阻性化脓性胆管炎 ✅
- E. 细菌性肝脓肿

答案：D

> 解析：在Charcot三联征（腹痛、寒战高热、黄疸）基础上出现休克与中枢神经系统受抑制，即Reynolds五联征，为急性梗阻性化脓性胆管炎（AOSC/ACST）的特征，病情凶险。参阅教材P475。

---

144. [A2型题 | 应用] batch032_M4_A2_005

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P527

男性，38岁。饮酒后突发左上腹剧烈疼痛，向腰背部放射，伴频繁呕吐，呕吐后腹痛不缓解。查体：上腹压痛，肠鸣音减弱，轻度腹胀。血淀粉酶显著升高，超声见胆囊内强回声影及胆管扩张。该急性胰腺炎最可能的病因是

- A. 胆源性（胆道结石） ✅
- B. 长期大量饮酒
- C. 高甘油三酯血症
- D. 药物性胰腺炎

- E. 自身免疫性胰腺炎

答案：A

> 解析：患者血淀粉酶升高、左上腹痛向腰背部放射、呕吐后不缓解，结合胆囊结石及胆管扩张，提示胆源性胰腺炎（占急性胰腺炎50%以上），结石经共同通道反流激活胰酶致病。参阅教材P527。

---

145. [A2型题｜应用] batch032_M4_A2_006

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P494

男性，65岁。进行性皮肤巩膜黄染1个月，伴消瘦、上腹隐痛。查体：巩膜黄染，可触及肿大胆囊、无压痛，肝肋下2cm。超声示胰钩突区占位、肝内外胆管扩张。最可能的诊断是

- A. 急性胆管炎
- B. 胆总管下端癌
- C. 壶腹癌
- D. 胰头癌 ✅
- E. 胆囊结石

答案：D

> 解析：胰头癌典型表现为进行性加重黄疸、Courvoisier征（胆囊肿大无压痛）、体重减轻；壶腹癌黄疸多波动性，胆总管下端癌胆囊常不肿大。参阅教材P494。

---

146. [B1型题｜记忆] batch032_M4_B1_001

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P453

门静脉与腔静脉间交通支中，离主干最近、压力差最大、最具临床意义的是：

- A. 食管胃底交通支 ✅
- B. 直肠肛管交通支
- C. 前腹壁脐周交通支
- D. 腹膜后静脉丛交通支
- E. 肠系膜静脉间交通支

答案：A

> 解析：食管胃底交通支离门静脉主干和腔静脉最近，压力差最大，受门静脉高压影响最早最显著，破裂可致致命大出血。参阅教材P453。

---

147. [B1型题 | 记忆] batch032_M4_B1_002

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P453

门静脉与腔静脉间可形成继发性痔的交通支是

- A. 胃底食管下段交通支
- B. 直肠肛管交通支 ✅
- C. 前腹壁脐周交通支
- D. 腹膜后静脉丛交通支
- E. 肠系膜静脉间交通支

答案：B

> 解析：直肠下端、肛管交通支：门静脉经肠系膜下静脉、直肠上静脉与直肠下静脉、肛管静脉吻合流入下腔静脉，扩张可致继发性痔。参阅教材P453。

---

148. [B1型题 | 记忆] batch032_M4_B1_003

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病 | 页码：教材P470

3：肝外胆管结石合并胆管炎时的典型表现是：

- A. 夏科三联征 ✅
- B. 雷诺五联征
- C. 墨菲征
- D. 库瓦西耶征
- E. 格雷特纳征

答案：A

> 解析：肝外胆管结石造成梗阻并继发胆管炎时出现Charcot三联征：腹痛、寒战高热、黄疸。参阅教材P470。

---

149. [B1型题｜理解] batch032_M4_B1_004

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P494

4：胰头癌压迫胆总管致胆囊肿大、但触诊无压痛，称为：

- A. 夏科三联征
- B. 雷诺五联征
- C. 墨菲征
- D. 库瓦西耶征 ✅
- E. 格雷特纳征

答案：D

> 解析：胰头癌压迫或浸润胆总管所致进行性黄疸，胆囊肿大但无压痛，称库瓦西耶（Courvoisier）征，有助于胰头癌与胆管下段结石的鉴别。参阅教材P494。

---

150. [X型题｜应用] batch032_M4_X_001

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P445

关于细菌性肝脓肿手术治疗的适应证，正确的有

- A. 脓肿较大、分隔较多 ✅
- B. 已穿破进入胸腔或腹腔 ✅
- C. 胆源性肝脓肿 ✅
- D. 单发小脓肿已液化
- E. 慢性肝脓肿（反复） ✅

答案：ABCE

> 解析：手术治疗适用于：脓肿较大、分隔较多；已穿破进入胸腔或腹腔；胆源性肝脓肿；慢性肝脓肿。单发小脓肿（3～5cm）多首选经皮穿刺置管引流而非手术。参阅教材P445。

151. [X型题｜理解] batch032_M4_X_002

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病丨页码：教材P454

门静脉高压症时，门-体交通支扩张可引起的表现包括

- A. 食管胃底静脉曲张 ✅
- B. 继发性痔（直肠静脉） ✅
- C. 前腹壁静脉曲张（海蛇头） ✅
- D. 腹膜后静脉丛曲张 ✅
- E. 下肢静脉曲张

答案：ABCD

> 解析：交通支扩张表现为：食管胃底静脉曲张、直肠上/下静脉丛扩张致痔、脐旁与腹上/下深静脉交通支扩张致前腹壁静脉曲张（海蛇头）、腹膜后Retzius丛曲张；下肢静脉曲张与本病无直接关系。参阅教材P454。

---

152. [X型题｜应用] batch032_M4_X_003

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病丨页码：教材P456

食管胃底曲张静脉破裂出血的非手术治疗措施包括

- A. 生长抑素持续静脉滴注 ✅
- B. 内镜下曲张静脉套扎术 ✅
- C. 三腔二囊管压迫止血 ✅
- D. 急诊门体分流术
- E. 质子泵抑制剂 ✅

答案：ABCE

> 解析：非手术治疗包括：补液输血、药物（生长抑素/奥曲肽、β受体拮抗剂等）、内镜治疗（EIS/EVL）、三腔二囊管压迫、TIPS及PPI等；急诊分流术属手术治疗，仅用于严格治疗无效者。参阅教材P456。

---

153. [X型题｜记忆] batch032_M4_X_004

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P470

肝外胆管结石合并急性胆管炎时，Charcot三联征的组成包括

- A. 反复发作腹痛 ✅
- B. 寒战伴高热 ✅
- C. 皮肤巩膜黄疸 ✅
- D. 失代偿性休克
- E. 神经精神症状

答案：ABC

> 解析：Charcot三联征为腹痛、寒战高热、黄疸；在此基础上出现休克与神经抑制则为Reynolds五联征（AOSC）。参阅教材P470。

---

154. [X型题｜理解] batch032_M4_X_005

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P482

与胆囊癌发生相关的危险因素包括

- A. 胆囊结石直径>3cm ✅
- B. 瓷化（钙化）胆囊 ✅
- C. 胆囊腺瘤性息肉 ✅
- D. 肝内外胆管结石
- E. 胆囊结石直径<1cm

答案：ABC

> 解析：胆囊癌与胆囊结石（直径3cm结石癌变率为1cm结石的10倍）、完全钙化的瓷化胆囊、胆囊腺瘤、胆胰管合流异常、溃疡性结肠炎等相关；胆管结石主要关联胆管癌。参阅教材P482。

---

155. [X型题｜理解] batch032_M4_X_006

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P527

急性胰腺炎的常见致病危险因素包括

- A. 胆道疾病（胆石症） ✅
- B. 长期大量饮酒 ✅
- C. 高甘油三酯血症 ✅
- D. 医源性ERCP ✅
- E. 十二指肠溃疡

答案：ABCD

> 解析：急性胰腺炎主要病因有胆道疾病（占50%以上）、饮酒、代谢性疾病（高脂血症、高钙血症）、十二指肠液反流、医源性ERCP（2%～10%）、药物、创伤等；十二指肠溃疡非其直接病因。参阅教材P527。

---

156. [X型题｜分析] batch032_M4_X_007

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P494

关于胰头癌临床表现的描述，正确的有

- A. 进行性加重的黄疸 ✅
- B. 上腹痛向腰背部放射 ✅
- C. 库瓦西耶征阳性 ✅
- D. 脂肪泻为突出表现
- E. 体重明显减轻 ✅

答案：ABCE

> 解析：胰头癌表现为进行性黄疸、上腹痛向腰背部放射（胰性疼痛）、Courvoisier征阳性、体重减轻；脂肪泻是慢性胰腺炎的四联症之一，非胰头癌突出表现。参阅教材P494。

---

157. [X型题｜记忆] batch032_M4_X_008

> 模块：肝疾病、门静脉高压症、胆道疾病、胰腺疾病｜页码：教材P469

胆囊结石可能发生的并发症有

- A. 梗阻性黄疸 ✅

- B. 胰腺炎 ✅
- C. 肠梗阻 ✅
- D. 胆囊癌 ✅
- E. 肝硬化

答案：ABCD

> 解析：胆囊结石可经胆囊管进入胆总管引起梗阻性黄疸；小结石通过Oddi括约肌可致胆源性胰腺炎；大结石经瘘管入肠偶致胆石性肠梗阻；结石及炎症长期刺激可诱发胆囊癌。[源:考研真题 GS-2019-163]

周围血管与淋巴疾病（28题）

158. [A1型题 | 记忆] batch032_M5_A1_001

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P324

动脉硬化性闭塞症（ASO）最常发生于下列哪类人群？

- A. 青壮年男性
- B. 45岁以上男性 ✅
- C. 青年女性
- D. 学龄期儿童
- E. 老年女性

答案：B

> 解析：动脉硬化性闭塞症多见于45岁以上男性，常同时伴有高血压、糖尿病、高脂血症等高危因素，属全身大中动脉病变；血栓闭塞性脉管炎才多见于青壮年男性。参阅教材P324。

---

159. [A1型题 | 记忆] batch032_M5_A1_002

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P325

血栓闭塞性脉管炎（Buerger病）最好发于哪类人群？

- A. 老年女性

- B. 婴幼儿
- C. 中年女性
- D. 青壮年男性 ✅
- E. 老年男性

答案：D

> 解析：血栓闭塞性脉管炎多侵袭四肢中、小动静脉，以下肢多见，好发于男性青壮年，主动或被动吸烟是重要危险因素。参阅教材P325。

---

160. [A1型题 | 记忆] batch032_M5_A1_003

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P328

周围动脉瘤中最常见的发病部位是？

- A. 颈总动脉
- B. 锁骨下动脉
- C. 股动脉和腘动脉 ✅
- D. 肱动脉主干
- E. 脾动脉主干

答案：C

> 解析：周围动脉瘤指主动脉以外动脉的局限性异常扩张，以股动脉瘤和腘动脉瘤最为常见，约占周围动脉瘤的90%。参阅教材P328。

---

161. [A1型题 | 记忆] batch032_M5_A1_004

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P329

在内脏动脉瘤中，发病率最高的是？

- A. 脾动脉瘤 ✅
- B. 肝动脉瘤
- C. 肠系膜上动脉瘤
- D. 肾动脉瘤

- E. 腹腔干动脉瘤

答案：A

> 解析：内脏动脉瘤以脾动脉瘤最常见（占60%），其次为肝动脉瘤（占20%）、肠系膜上动脉瘤（占8%）。参阅教材P329。

---

162. [A1型题｜记忆] batch032_M5_A1_005

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P331

大隐静脉最终汇入下列哪条静脉？

- A. 腘静脉
- B. 小隐静脉
- C. 髂外静脉
- D. 胫后静脉
- E. 股总静脉 ✅

答案：E

> 解析：大隐静脉是人体最长的静脉，起自足背静脉网内侧，沿小腿和大腿内侧上行，在腹股沟韧带下穿过卵圆窝注入股总静脉。参阅教材P331。

---

163. [A1型题｜理解] batch032_M5_A1_006

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P326

急性动脉栓塞典型的“5P”征中，不包括下列哪一项？

- A. 疼痛
- B. 苍白
- C. 无脉
- D. 感觉异常
- E. 高热 ✅

答案：E

> 解析：急性动脉栓塞典型表现为“5P”征，即疼痛（pain）、苍白（pallor）、无脉（pulselessness）、感觉异常（paresthesia）和运动障碍（paralysis）。高热并非其表现。参阅教材P326。

---

164. [A1型题 | 理解] batch032_M5_A1_007

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P334

深静脉血栓形成的Virchow三大因素不包括？

- A. 静脉壁损伤
- B. 血流缓慢
- C. 血液高凝状态
- D. 淋巴管回流障碍 ✅
- E. 长期卧床制动

答案：D

> 解析：Virchow提出深静脉血栓形成的三大因素为静脉损伤、血流缓慢和血液高凝状态；长期卧床制动是引起血流缓慢的外因。淋巴管回流障碍不属于该三大因素。参阅教材P334。

---

165. [A1型题 | 理解] batch032_M5_A1_008

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P332

下列哪项不是原发性下肢静脉曲张的主要病因？

- A. 静脉壁薄弱
- B. 静脉瓣膜缺陷
- C. 浅静脉内压升高
- D. 遗传因素
- E. 淋巴回流障碍 ✅

答案：E

> 解析：原发性下肢静脉曲张的主要原因为静脉壁薄弱、静脉瓣膜缺陷及浅静脉内压升高，静脉壁薄弱和瓣膜缺陷与遗传有关；淋巴回流障碍并非其病因。参阅教材P332。

166. [A1型题｜理解] batch032_M5_A1_009

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P324

测定踝肱指数（ABI）为0.5时，提示下肢动脉处于何种状态？

- A. 正常血供
- B. 中度缺血状态 ✅
- C. 严重缺血状态
- D. 静脉淤血状态
- E. 淋巴水肿状态

答案：B

> 解析：踝肱指数（ABI）正常值为0.9～1.3，＜0.9提示动脉缺血，＜0.4提示严重缺血。0.5介于两者之间，属动脉缺血状态。参阅教材P324。

---

167. [A1型题｜理解] batch032_M5_A1_010

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P322

肢体体位性色泽改变试验（Buerger试验）阳性，主要提示？

- A. 动脉供血障碍 ✅
- B. 静脉回流障碍
- C. 淋巴回流障碍
- D. 神经感觉异常
- E. 皮肤感染

答案：A

> 解析：Buerger试验即体位性色泽改变试验，抬高下肢70°～80°持续60秒呈苍白，下垂后恢复时间超过45秒且色泽不均，提示动脉供血障碍。参阅教材P322。

---

168. [A1型题 | 理解] batch032_M5_A1_011

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P325

血栓闭塞性脉管炎的病变进展特点主要是？

- A. 由近端向远端蔓延
- B. 由远端向近端节段分布 ✅
- C. 仅累及大中动脉
- D. 以静脉病变为主
- E. 钙化非常明显

答案：B

> 解析：血栓闭塞性脉管炎通常始于动脉，再累及静脉，由远端向近端进展，呈节段性分布，两段之间血管相对正常。参阅教材P325。

---

169. [A1型题 | 理解] batch032_M5_A1_012

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P328

动脉瘤触诊时肿块的搏动特点是？

- A. 与脉搏无关
- B. 传导性搏动
- C. 随呼吸搏动
- D. 无明确搏动
- E. 膨胀性搏动 ✅

答案：E

> 解析：动脉瘤最典型的表现为搏动性肿块，触诊具有膨胀性而非传导性搏动，且与心脏搏动一致，可伴震颤和收缩期杂音。参阅教材P328。

---

170. [A1型题 | 应用] batch032_M5_A1_013

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P324

一动脉硬化闭塞症患者测定踝肱指数（ABI）为0.5，该患者下肢应判断为？

- A. 正常血供
- B. 淋巴水肿状态
- C. 严重缺血状态
- D. 静脉淤血状态
- E. 中度缺血状态 ✅

答案：E

> 解析：ABI正常0.9～1.3，＜0.9提示动脉缺血，＜0.4提示严重缺血。该患者ABI 0.5，应判为动脉缺血状态，尚未达严重缺血。参阅教材P324。

---

171. [A1型题 | 应用] batch032_M5_A1_014

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P325

对血栓闭塞性脉管炎患者而言，最应强调干预的危险因素是？

- A. 高血压
- B. 糖尿病
- C. 吸烟 ✅
- D. 高脂血症
- E. 肥胖

答案：C

> 解析：血栓闭塞性脉管炎确切病因未明，但主动或被动吸烟是本病发生和发展的重要危险因素，戒烟是防止病变进展的关键措施。参阅教材P325。

---

172. [A1型题 | 应用] batch032_M5_A1_015

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P336

下肢深静脉血栓患者存在抗凝治疗禁忌时，为预防肺动脉栓塞首选？

- A. 抬高患肢

- B. 下腔静脉滤器植入 ✅
- C. 静脉曲张剥脱
- D. 动脉取栓术
- E. 弹力袜压迫

答案：B

> 解析：下腔静脉滤器植入适用于存在抗凝禁忌的深静脉血栓病人，可减少和预防肺动脉栓塞的发生，但植入有严格指征，首选可回收滤器。参阅教材P336。

---

173. [A1型题 | 分析] batch032_M5_A1_016

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P325

鉴别动脉硬化性闭塞症与血栓闭塞性脉管炎，最关键的临床依据是？

- A. 发病年龄、血管口径 ✅
- B. 有无间歇性跛行
- C. 有无静息痛
- D. 有无下肢溃疡
- E. 有无皮温降低

答案：A

> 解析：动脉硬化性闭塞症多见于45岁以上、累及大中小动脉，常伴高血压糖尿病；血栓闭塞性脉管炎多见于青壮年男性、累及中小动静脉，常有游走性浅静脉炎。发病年龄与受累血管口径是最关键鉴别点。参阅教材P325。

---

174. [A2型题 | 应用] batch032_M5_A2_001

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P324

男性，58岁。反复行走后小腿酸痛伴间歇性跛行3年，近2个月静息时亦感足趾疼痛。查体：左足皮温降低、苍白，股动脉及足背动脉搏动消失，有高血压、糖尿病史。最可能的诊断是？

- A. 血栓闭塞性脉管炎

- B. 动脉硬化性闭塞症 ✅
- C. 下肢深静脉血栓
- D. 雷诺综合征
- E. 下肢动脉栓塞

答案：B

> 解析：患者为45岁以上男性，有间歇性跛行进展至静息痛，足背动脉搏动消失，且伴高血压、糖尿病等动脉硬化高危因素，符合动脉硬化性闭塞症；血栓闭塞性脉管炎多见于青壮年吸烟男性。参阅教材P324。

---

175. [A2型题｜应用] batch032_M5_A2_002

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P325

男性，32岁。吸烟10年，近半年来左足发凉、间歇性跛行，足背动脉搏动减弱，既往反复出现左小腿游走性浅静脉炎。最可能的诊断是？

- A. 动脉硬化性闭塞症
- B. 下肢静脉曲张
- C. 急性动脉栓塞
- D. 血栓闭塞性脉管炎 ✅
- E. 糖尿病足

答案：D

> 解析：青年男性、吸烟嗜好、间歇性跛行、足背动脉搏动减弱并伴有游走性浅静脉炎病史，是血栓闭塞性脉管炎的典型表现；动脉硬化性闭塞症多见于老年且少有浅静脉炎。参阅教材P325。

---

176. [A2型题｜应用] batch032_M5_A2_003

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P327

女性，68岁。风湿性心脏病房颤多年，突发右下肢剧烈疼痛、苍白、麻木、足背动脉消失2小时。此时最重要的紧急处理是？

- A. 镇痛并观察

- B. 急症取栓术 ✅
- C. 静脉溶栓治疗
- D. 抬高患肢
- E. 抗感染治疗

答案：B

> 解析：患者有房颤史并突发下肢“5P”征，考虑心源性急性动脉栓塞。凡诊断明确、全身情况允许，尤其大、中动脉栓塞应尽早手术，动脉切开取栓或Fogarty球囊导管取栓是主要手段。参阅教材P327。

---

177. [A2型题｜理解] batch032_M5_A2_004

> 模块：周围血管与淋巴疾病｜页码：教材P335

男性，50岁。直肠癌术后卧床1周，突发左下肢肿胀、胀痛，踝关节过度背伸试验致小腿剧痛（Homans征阳性）。为明确诊断，首选的检查是？

- A. 胸部X线
- B. 静脉造影
- C. 动脉造影
- D. 多普勒超声 ✅
- E. 血常规

答案：D

> 解析：术后卧床、下肢突发肿胀胀痛、Homans征阳性提示下肢深静脉血栓形成。多普勒超声可显示静脉腔内强回声、静脉不可压缩或无血流等血栓征象，是确诊的首选无创检查。参阅教材P335。

---

178. [B1型题｜应用] batch032_M5_B1_001

> 模块：周围血管与淋巴疾病｜页码：教材P336

下肢骨折后7天，起床时突然死亡，尸体解剖时最可能的发现是：

- A. 肺动脉血栓栓塞 ✅

- B. 肺动脉脂肪栓塞
- C. 肺动脉血栓形成
- D. 肺毛细血管血栓形成
- E. 肺动脉空气栓塞

答案：A

> 解析：下肢骨折后长期卧床易发生下肢深静脉血栓形成，起床时血栓脱落随血流进入肺动脉，造成肺动脉血栓栓塞而猝死；脂肪栓塞多在伤后1～3天发生，肺动脉血流快、原位血栓形成罕见，中毒性休克晚期才出现肺毛细血管透明血栓。故答A。[源:考研真题 GS-2013-137]

---

179. [B1型题｜记忆] batch032_M5_B1_002

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P328

周围动脉瘤最具特征性的临床表现是：

- A. 搏动性肿块伴收缩期杂音 ✅
- B. 间歇跛行与静息痛
- C. 苍白-青紫-潮红顺序发作
- D. 肢体象皮样增厚
- E. 患肢增长增粗伴皮温升高

答案：A

> 解析：周围动脉瘤最典型的临床表现为搏动性肿块和杂音，肿块触诊具有膨胀性而非传导性搏动，与心脏搏动一致，可伴震颤和收缩期杂音。参阅教材P328。

---

180. [B1型题｜理解] batch032_M5_B1_003

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P327

雷诺综合征典型的临床表现是

- A. 搏动性肿块伴收缩期杂音
- B. 间歇跛行与静息痛
- C. 苍白-青紫-潮红顺序发作 ✅

- D. 肢体象皮样增厚
- E. 患肢增长增粗伴皮温升高

答案：C

> 解析：雷诺综合征典型症状是顺序出现苍白、青紫和潮红：苍白因小动脉痉挛缺血，青紫因毛细血管淤血，潮红因反应性充血。参阅教材P327。

---

181. [X型题 | 记忆] batch032_M5_X_001

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P334

深静脉血栓形成的Virchow三大要素包括下列哪些？

- A. 静脉壁损伤 ✅
- B. 血流缓慢 ✅
- C. 血液高凝状态 ✅
- D. 静脉瓣膜缺陷
- E. 淋巴管阻塞

答案：ABC

> 解析：Virchow提出深静脉血栓形成三大因素：①静脉损伤（壁损伤、内皮损害）；②血流缓慢（久病卧床、制动、久坐）；③血液高凝状态（妊娠、术后、肿瘤等）。静脉瓣膜缺陷与淋巴管阻塞不属此三大要素，故不选D、E。参阅教材P334。

---

182. [X型题 | 记忆] batch032_M5_X_002

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P337

继发性淋巴水肿的常见原因包括下列哪些？

- A. 手术或创伤破坏淋巴系统 ✅
- B. 放射治疗后的纤维化 ✅
- C. 肿瘤浸润或阻塞淋巴管 ✅
- D. 反复发作的细菌感染 ✅
- E. 先天性淋巴管发育不全

答案：ABCD

> 解析：继发性淋巴水肿常见原因有：手术或创伤造成淋巴系统破坏、放疗后纤维化、肿瘤对淋巴系统的浸润与阻塞、慢性细菌感染（如乙型溶血性链球菌）等。先天性淋巴管发育不全属于原发性淋巴水肿，故不选E。参阅教材P337。

---

183. [X型题｜理解] batch032_M5_X_003

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P325

下列哪些表现支持动脉硬化性闭塞症（ASO）而非血栓闭塞性脉管炎的诊断？

- A. 发病年龄45岁以上 ✅
- B. 大、中动脉为主受累 ✅
- C. 常伴高血压、糖尿病 ✅
- D. 反复游走性浅静脉炎
- E. 动脉造影呈广泛不规则狭窄 ✅

答案：ABCE

> 解析：动脉硬化性闭塞症多见于45岁以上，累及大中小动脉，常伴高血压、冠心病、高脂血症、糖尿病，动脉造影呈广泛性不规则狭窄和节段性闭塞；反复游走性浅静脉炎是血栓闭塞性脉管炎的特征，故不选D。参阅教材P325。

---

184. [X型题｜理解] batch032_M5_X_004

> 模块：周围血管与淋巴疾病丨页码：教材P336

下肢深静脉血栓形成的非手术治疗措施包括下列哪些？

- A. 抗凝治疗 ✅
- B. 溶栓治疗 ✅
- C. 祛聚药物 ✅
- D. 抬高患肢 ✅
- E. 动脉瘤切除

答案：ABCD

> 解析：深静脉血栓非手术治疗包括：一般处理（卧床休息、抬高患肢、弹力袜）、祛聚药物（阿司匹林、右旋糖酐）、抗凝治疗（基本治疗）及溶栓治疗；动脉瘤切除用于动脉瘤，不属深静脉血栓治疗，故不选E。参阅教材P336。

---

185. [X型题 | 分析] batch032_M5_X_005

> 模块：周围血管与淋巴疾病 | 页码：教材P333

诊断原发性下肢静脉曲张时，需与之鉴别的疾病包括下列哪些？

- A. 深静脉瓣膜功能不全 ✅
- B. 深静脉血栓后综合征 ✅
- C. 下肢动静脉瘘 ✅
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 下肢淋巴水肿

答案：ABC

> 解析：原发性下肢静脉曲张的诊断必须排除：①原发性下肢深静脉瓣膜功能不全；②深静脉血栓形成后综合征；③动静脉瘘（病肢皮温升高、有震颤杂音、静脉血氧含量增高）。血栓闭塞性脉管炎与淋巴水肿不属该鉴别清单，故不选D、E。参阅教材P333。

泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）（38题）

186. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_001

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P527

关于肾损伤严重程度与临床表现的关系，下列描述正确的是：

- A. 血尿程度与肾损伤严重程度呈正相关
- B. 血尿程度与肾损伤严重程度有时不一致 ✅
- C. 肾挫伤多伴有大量肉眼血尿
- D. 肾全层裂伤主要表现为镜下血尿
- E. 无血尿基本可排除肾损伤

答案：B

> 解析：教材指出血尿程度与肾损伤的严重程度有时并不一致，如肾蒂血管破裂可无明显血尿而病情凶险，应结合影像学与生命体征综合判断。（参阅教材P527）

---

187. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_002

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P534

男性前尿道损伤多发生于：

- A. 前列腺部
- B. 尿道舟状窝
- C. 尿道膜部
- D. 尿道外口
- E. 尿道球部 ✅

答案：E

> 解析：男性前尿道包括阴茎部和球部，前尿道损伤多发生于球部；会阴部骑跨伤将尿道挤向耻骨联合下方，易引起尿道球部损伤。（参阅教材P534）

---

188. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_003

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P553

良性前列腺增生主要发生于前列腺的：

- A. 外周带
- B. 中央带
- C. 移行带 ✅
- D. 尿道旁腺
- E. 精阜

答案：C

> 解析：BPH主要发生于围绕尿道的移行带，增生组织突向后尿道与膀胱颈，引起膀胱出口梗阻及下尿路症状。（参阅教材P553）

---

189. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_004

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P574

前列腺癌最常见的转移部位是

- A. 肝脏
- B. 肺脏
- C. 脑实质
- D. 肾上腺
- E. 骨骼 ✅

答案：E

> 解析：前列腺癌可经血行、淋巴转移或直接侵及邻近器官（如精囊、膀胱）；最常见的转移部位是淋巴结和骨骼，血行转移最常累及骨骼。[源:教材P574]

---

190. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_005

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P570

膀胱癌最常见的首发症状是：

- A. 尿频尿急尿痛
- B. 骨骼疼痛
- C. 进行性排尿困难
- D. 下腹部包块
- E. 间歇无痛全程血尿 ✅

答案：E

> 解析：80%～90%的膀胱癌病人以间歇性、无痛性、全程肉眼血尿为首发症状，可自行减轻或停止，易延误诊治。（参阅教材P570）

191. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_006

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P564

肾癌中最常见的病理类型是：

- A. 肾母细胞瘤
- B. 乳头状细胞癌
- C. 嫌色细胞癌
- D. 集合管癌
- E. 透明细胞癌 ✅

答案：E

> 解析：肾癌病理类型以透明细胞癌最多见，占70%～80%，因胞质内含大量脂质、糖原被溶解而呈透明状。（参阅教材P564）

---

192. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_007

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P559

泌尿系统结石中质地硬、不易碎、呈桑葚样棕褐色的常见结石是：

- A. 胱氨酸结石
- B. 磷酸镁铵结石
- C. 尿酸结石
- D. 草酸钙结石 ✅
- E. 碳酸盐结石

答案：D

> 解析：草酸钙结石最常见，质硬、不易碎、粗糙、不规则、呈桑葚样、棕褐色，尿路平片易显影；尿酸与胱氨酸结石为X线阴性结石。（参阅教材P559）

---

193. [A1型题｜理解] batch032_M6_A1_008

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P548

肾结核出现“肾自截”是指：

- A. 肾钙化且输尿管闭塞、症状缓解 ✅
- B. 肾肿瘤自发破裂
- C. 肾盂输尿管连接部自行通畅
- D. 肾积水自行消退
- E. 结核病灶完全吸收痊愈

答案：A

> 解析：少数肾结核全肾广泛钙化、肾功能完全丧失、输尿管闭塞，含菌尿液不能流入膀胱，膀胱继发结核好转、症状缓解，称“肾自截”；但病灶内仍有活结核杆菌，仍可作为病源，不可忽视。（参阅教材P548）

---

194. [A1型题｜记忆] batch032_M6_A1_009

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P563

膀胱结石的典型症状是：

- A. 无痛性肉眼血尿
- B. 尿道滴白
- C. 持续性尿频
- D. 急性尿潴留
- E. 排尿中断伴放射痛 ✅

答案：E

> 解析：膀胱结石典型症状为排尿突然中断，疼痛放射至远端尿道及阴茎头部，伴排尿困难与膀胱刺激症状。（参阅教材P563）

---

195. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_010

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P540

急性肾盂肾炎最常见的致病菌是：

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 淋病奈瑟菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 结核分枝杆菌
- E. 大肠埃希菌 ✅

答案：E

> 解析：急性肾盂肾炎致病菌主要为大肠埃希菌及其他肠杆菌，多由尿道上行感染经输尿管至肾脏，女性发病率高于男性。（参阅教材P540）

---

196. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_011

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P519

尿三杯试验中第三杯尿液异常，提示病变部位在：

- A. 尿道外口
- B. 输尿管下段
- C. 膀胱或上尿路
- D. 前列腺部
- E. 膀胱颈部或后尿道 ✅

答案：E

> 解析：尿三杯试验：第一杯异常提示尿道病变；第三杯异常提示膀胱颈部或后尿道病变；三杯均异常提示膀胱或上尿路病变。注意结合镜检判断。（参阅教材P519）

---

197. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_012

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P520

血清前列腺特异性抗原（PSA）正常参考值为：

- A. 0～4ng/ml ✅
- B. 4～10ng/ml
- C. 10～20ng/ml
- D. 20～40ng/ml
- E. ＞40ng/ml

答案：A

> 解析：血清PSA正常值为0～4ng/ml，升高提示前列腺癌可能，但亦受年龄、前列腺体积、前列腺炎、操作等影响，宜在直肠指诊前完成测定。（参阅教材P520）

---

198. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_013

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）| 页码：教材P559

输尿管结石最常停留或嵌顿的部位是：

- A. 肾盂输尿管连接处
- B. 输尿管跨髂血管处
- C. 输尿管膀胱壁段 ✅
- D. 输尿管上段
- E. 肾盏颈部

答案：C

> 解析：输尿管有三个生理狭窄（肾盂输尿管连接处、跨髂血管处、膀胱壁段），结石常停留于三处狭窄，以输尿管下1/3处最多见。（参阅教材P559）

---

199. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_014

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）| 页码：教材P561

体外冲击波碎石（ESWL）适用于直径≤2cm的：

- A. 肾及输尿管上段结石 ✅

- B. 所有肾结石
- C. 膀胱内结石
- D. 输尿管下段结石
- E. 鹿角形结石

答案：A

> 解析：ESWL适应证为直径≤2cm的肾结石及输尿管上段结石；输尿管中下段结石成功率较低，鹿角形等复杂结石常需PCNL等联合治疗。（参阅教材P561）

---

200. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_015

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P526

关于隐睾症的描述，正确的是：

- A. 腹腔内隐睾恶变概率高约40倍 ✅
- B. 1岁后睾丸多不能自行下降
- C. 单侧隐睾不影响生育
- D. 阴囊温度低于体温不利于生精
- E. 隐睾极少发生恶变

答案：A

> 解析：隐睾受温度影响导致生精障碍，双侧不育达50%以上、单侧达30%以上；隐睾尤其腹膜后者恶变概率较普通人高约40倍。1岁内可观察，2岁前未降应手术。（参阅教材P526）

---

201. [A1型题 | 记忆] batch032_M6_A1_016

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P583

嗜铬细胞瘤的典型三联征是：

- A. 头痛、心悸、出汗 ✅
- B. 高血压、低血钾、多尿
- C. 向心性肥胖、紫纹、高血压
- D. 腹痛、腹泻、消瘦

- E. 发热、关节痛、皮疹

答案：A

> 解析：头痛、心悸、出汗是嗜铬细胞瘤典型三联征，对儿茶酚胺增多症诊断具90%以上的特异度与灵敏度。（参阅教材P583）

---

202. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_017

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P579

原醛症最常见的亚型是

- A. 特发性醛固酮增多症 ✅
- B. 醛固酮腺瘤
- C. 单侧肾上腺增生
- D. 肾上腺皮质癌
- E. 异位分泌肿瘤

答案：A

> 解析：IHA约占PHA的60%，为最常见亚型，表现为双侧肾上腺球状带增生，对体位改变等刺激仍有响应。（参阅教材P579）

---

203. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_018

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P582

库欣综合征中由垂体瘤或下丘脑功能紊乱所致者称为：

- A. 结节性肾上腺增生
- B. 异位ACTH综合征
- C. 肾上腺皮质腺瘤
- D. 肾上腺皮质癌
- E. Cushing病 ✅

答案：E

> 解析：ACTH依赖性CS中Cushing病占70%～80%，由垂体瘤或下丘脑功能紊乱致腺垂体分泌过多ACTH引起；异位ACTH综合征源于垂体外肿瘤。（参阅教材P582）

---

204. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_019

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P524

成人型多囊肾（ADPKD）的遗传方式是：

- A. 常染色体显性遗传 ✅
- B. 常染色体隐性遗传
- C. X连锁遗传
- D. 线粒体遗传
- E. 多基因遗传

答案：A

> 解析：成人型多囊肾属常染色体显性遗传，PKD1（16号染色体短臂）占85%～90%，PKD2占5%～10%；婴儿型为常染色体隐性遗传。（参阅教材P524）

---

205. [A1型题 | 理解] batch032_M6_A1_020

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P566

肾母细胞瘤（Wilms瘤）最常见和最重要的症状是：

- A. 腹部肿块 ✅
- B. 血尿
- C. 高血压
- D. 腹痛
- E. 发热

答案：A

> 解析：无症状腹部肿块是肾母细胞瘤最常见、最重要的症状，见于90%以上病儿，常位于上腹一侧季肋部，表面光滑、中等硬度。（参阅教材P566）

206. [A1型题｜理解] batch032_M6_A1_021

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P578

睾丸肿瘤发病关系密切的因素是：

- A. 前列腺炎
- B. 尿道炎
- C. 包皮过长
- D. 精索静脉曲张
- E. 隐睾症 ✅

答案：E

> 解析：隐睾与睾丸肿瘤关系密切，隐睾发生睾丸肿瘤概率为正常人群的3～14倍，即使早期下降固定也不能完全防止恶变。（参阅教材P578）

---

207. [A1型题｜理解] batch032_M6_A1_022

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P567

肾错构瘤具特征性的影像表现是

- A. 病灶均匀强化
- B. 明显钙化灶
- C. 脂肪密度灶 ✅
- D. 囊变坏死区
- E. 动脉期快进快出

答案：C

> 解析：错构瘤由血管、平滑肌和脂肪组成，CT示斑片状极低密度脂肪影（CT值＜-20HU），特征性脂肪密度可与肾癌鉴别；超声因脂肪呈强回声。（参阅教材P567）

---

208. [A2型题 | 应用] batch032_M6_A2_001

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P534

男性，28岁。骑跨于硬物后出现会阴部肿胀、瘀斑，尿道口滴血，排尿困难。最可能的诊断是：

- A. 后尿道膜部伤
- B. 肾实质裂伤
- C. 膀胱破裂
- D. 前尿道球部伤 ✅
- E. 直肠损伤

答案：D

> 解析：会阴部骑跨伤将尿道挤向耻骨联合下方，最易伤及前尿道球部，表现为尿道出血、会阴肿胀瘀斑及排尿困难，符合前尿道损伤。（参阅教材P534）

---

209. [A2型题 | 应用] batch032_M6_A2_002

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P555

男性，65岁。进行性排尿困难3年，夜尿4～5次/夜，伴尿线变细。首选的初步检查是：

- A. 血清PSA测定
- B. 肛门直肠指诊 ✅
- C. 膀胱镜检查
- D. CT尿路成像
- E. 尿流率测定

答案：B

> 解析：50岁以上男性出现LUTS应首先考虑BPH，直肠指诊是重要检查方法，可触及增大、质韧、中央沟变浅的前列腺；PSA用于排除前列腺癌。（参阅教材P555）

---

210. [A2型题 | 应用] batch032_M6_A2_003

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P571

男性，58岁。间歇性无痛性肉眼血尿2个月，B超发现腔内占位性病变。确诊最可靠的方法是

- A. 尿常规
- B. 静脉尿路造影
- C. 腹部CT
- D. 尿脱落细胞学
- E. 膀胱镜活检 ✅

答案：E

> 解析：中老年无痛性肉眼血尿应警惕膀胱癌，病理活检是诊断膀胱癌最可靠的方法；膀胱镜可直接观察肿瘤并取活检。（参阅教材P571）

---

211. [A2型题 | 应用] batch032_M6_A2_004

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P535

男性，40岁。车祸致骨盆骨折，不能排尿，尿道外口仅有少量血液，下腹膨隆。最可能的诊断是：

- A. 前尿道球部损伤
- B. 后尿道膜部损伤 ✅
- C. 膀胱壁挫伤
- D. 肾实质挫伤
- E. 输尿管损伤

答案：B

> 解析：骨盆骨折常致后尿道（膜部）撕裂，尿道外口无或仅少量血液，伴排尿困难、尿潴留及耻骨后血肿，符合后尿道损伤。（参阅教材P535）

---

212. [A2型题｜应用] batch032_M6_A2_005

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P580

女性，42岁。发作性肌无力伴高血压2年，血钾2.8mmol/L，肾素活性降低。最可能的诊断是：

- A. 原发性高血压
- B. 库欣综合征
- C. 原发性醛固酮增多症 ✅
- D. 嗜铬细胞瘤
- E. 肾血管性高血压

答案：C

> 解析：原醛症表现为高血压、低血钾、低肾素、碱中毒及肌无力；血浆醛固酮/肾素活性比值（ARR）＞30∶1支持诊断，需进一步行确诊试验。（参阅教材P580）

---

213. [B1型题｜理解] batch032_M6_B1_001

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P534

会阴部骑跨伤后出现排尿困难、尿道滴血的泌尿系统损伤最常见部位是：

- A. 后尿道
- B. 尿道球部 ✅
- C. 腹膜内膀胱
- D. 腹膜外膀胱
- E. 尿道膜部

答案：B

> 解析：前尿道损伤多见于骑跨伤，多为球部损伤（记忆为前骑球）；后尿道损伤多见于骨盆骨折，多为膜部损伤（记忆为后骨膜）。本题骑跨伤致前尿道球部损伤。［源:考研真题 GS-2015-147］

---

214. [B1型题｜理解] batch032_M6_B1_002

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P517

老年男性前列腺增生致膀胱出口梗阻，膀胱过度充盈后尿液呈滴沥状不自主溢出，属于：

- A. 持续性尿失禁
- B. 充溢性尿失禁 ✅
- C. 急迫性尿失禁
- D. 压力性尿失禁
- E. 夜间遗尿症

答案：B

> 解析：充溢性尿失禁见于BPH、尿道狭窄等慢性下尿路梗阻，膀胱内压超过尿道阻力后尿液滴沥溢出；解除梗阻多可治愈，又称“假性尿失禁”。（参阅教材P517）

---

215. [B1型题｜理解] batch032_M6_B1_003

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P517

2：中年女性咳嗽、大笑、喷嚏时少量尿液不自主流出，平时控制正常，属于：

- A. 持续性尿失禁
- B. 充溢性尿失禁
- C. 急迫性尿失禁
- D. 压力性尿失禁 ✅
- E. 夜间遗尿症

答案：D

> 解析：压力性尿失禁指腹压增加时少量尿液不自主流出，多见于多产妇或绝经后女性，因阴道前壁支撑下降、盆腔组织功能障碍所致。（参阅教材P517）

---

216. [B1型题｜理解] batch032_M6_B1_004

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P574

前列腺癌最常发生的部位是：

- A. 前列腺移行带
- B. 前列腺外周带 ✅
- C. 肾皮质肾小球周围
- D. 膀胱黏膜上皮
- E. 肾盂肾盏黏膜

答案：B

> 解析：前列腺癌好发于前列腺外周带，常为多病灶起源；而BPH发生于移行带，两者部位不同有助于鉴别。（参阅教材P574）

---

217. [X型题 | 应用] batch032_M6_X_001

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P565

关于肾癌的副瘤综合征，下列表现中可出现的有：

- A. 不明原因发热 ✅
- B. 高血压 ✅
- C. 红细胞增多 ✅
- D. 高钙血症 ✅
- E. 低血糖

答案：ABCD

> 解析：副瘤综合征见于10%～20%肾癌，因肿瘤释放细胞因子或激素所致，可表现为发热、高血压（肾素）、红细胞增多（促红细胞生成素）、高钙血症（甲状旁腺素样物质）等；肾癌对放化疗不敏感，低血糖非其典型表现。E不选。（参阅教材P565）

---

218. [X型题 | 应用] batch032_M6_X_002

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P561

上尿路结石采用药物排石治疗的适应证包括：

- A. 结石直径＜0.6cm ✅

- B. 结石表面光滑 ✅
- C. 结石以下尿路无梗阻 ✅
- D. 结石直径＞2cm
- E. 合并严重感染

答案：ABC

> 解析：药物排石适用于结石直径＜0.6cm、表面光滑、结石以下尿路无梗阻者；直径＞2cm或合并严重感染不宜单纯药物排石，常需ESWL、PCNL等干预。D、E不选。（参阅教材P561）

---

219. [X型题｜应用] batch032_M6_X_003

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P571

非肌层浸润性膀胱癌（TURBT术后）可选用的膀胱灌注药物有：

- A. 丝裂霉素 ✅
- B. 表柔比星 ✅
- C. 卡介苗 ✅
- D. 吉西他滨
- E. 别嘌醇

答案：ABC

> 解析：NMIBC术后行膀胱灌注化疗（丝裂霉素、表柔比星、吡柔比星等）或免疫制剂BCG；BCG疗效优于化疗，一般术后2周使用。顺铂多为全身化疗用药，别嘌醇用于尿酸结石，D、E不选。（参阅教材P571）

---

220. [X型题｜应用] batch032_M6_X_004

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P549

肾结核常见的晚期并发症包括：

- A. 膀胱挛缩 ✅
- B. 对侧肾积水 ✅
- C. 结核性脓肾 ✅

- D. 尿道狭窄 ✅
- E. 急性肾小球肾炎

答案：ABCD

> 解析：肾结核晚期并发症包括膀胱挛缩（容量＜50ml）、对侧肾积水（输尿管口狭窄或闭合不全）、结核性脓肾及尿道狭窄（后尿道受累）。急性肾小球肾炎非肾结核并发症，E不选。（参阅教材P549）

---

221. [X型题｜应用] batch032_M6_X_005

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P557

良性前列腺增生出现下列哪些情况建议外科治疗：

- A. 反复尿潴留 ✅
- B. 反复血尿 ✅
- C. 反复泌尿系感染 ✅
- D. 继发上尿路积水 ✅
- E. 偶发轻度尿频

答案：ABCD

> 解析：BPH出现反复尿潴留、反复血尿、反复感染、膀胱结石、继发上尿路积水及合并腹股沟疝等并发症时建议手术；偶发轻度症状可观察等待，E不选。（参阅教材P557）

---

222. [X型题｜分析] batch032_M6_X_006

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生）｜页码：教材P534

关于前、后尿道损伤临床表现的差异，下列说法正确的有：

- A. 前尿道损伤多见于球部 ✅
- B. 后尿道损伤多见于膜部 ✅
- C. 前尿道损伤尿道外口滴血 ✅
- D. 后尿道损伤尿道外口少血 ✅
- E. 两者必有大量全程血尿

答案：ABCD

> 解析：前尿道（球部）损伤多因骑跨伤，尿道外口滴血明显；后尿道（膜部）损伤多因骨盆骨折，尿道外口无或少量血，伴耻骨后血肿。血尿程度与损伤严重度未必一致，E错误不选。（参阅教材P534、P535）

---

223. [X型题 | 分析] batch032_M6_X_007

> 模块：泌尿系统疾病（损伤、感染、结石、肿瘤、良性前列腺增生） | 页码：教材P555

良性前列腺增生需与之鉴别的疾病包括：

- A. 前列腺癌 ✅
- B. 膀胱颈挛缩 ✅
- C. 尿道狭窄 ✅
- D. 神经源性膀胱 ✅
- E. 急性肾盂肾炎

答案：ABCD

> 解析：BPH引起排尿困难，需与前列腺癌（结节、PSA升高）、膀胱颈挛缩（年轻、前列腺不大）、尿道狭窄（损伤感染史）、神经源性膀胱（动力性梗阻、前列腺不大）鉴别；急性肾盂肾炎以感染中毒症状为主，非主要鉴别疾病，E不选。（参阅教材P555、P574）

骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折（44题）

224. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_001

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2021-065

站立前期发育性髋关节脱位的典型体征是

- A. 屈髋外展畸形
- B. 骨盆挤压试验
- C. 摇摆式跛行
- D. 弹入试验(+) ✅

- E. 套叠试验(+)

答案：D

> 解析：站立前期病儿仰卧位，屈膝、屈髋各90°，当髋外展至一定角度后突然弹跳者为弹入试验(Ortolani试验)阳性，说明脱位的股骨头通过杠杆作用滑入髋臼，见于先天性髋关节脱位（发育性髋关节脱位）；Ortolani试验只适合3个月以内的婴儿。屈髋畸形、摇摆式跛行为站立期表现，骨盆挤压试验(+)为骨盆骨折表现。[源:考研真题 GS-2021-065]

---

225. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_002

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2014-149

桡骨远端屈曲型骨折，骨折近端向背侧移位，远端向掌侧、桡侧移位，称为

- A. Colles骨折
- B. Smith骨折 ✅
- C. Galeazzi骨折
- D. Barton骨折
- E. Monteggia骨折

答案：B

> 解析：Smith骨折也称桡骨远端屈曲型骨折，骨折近端向背侧移位，远端向掌侧、桡侧移位。盖氏(Galeazzi)骨折指桡骨干下1/3骨折合并尺骨小头脱位；孟氏(Monteggia)骨折指尺骨上1/3骨干骨折合并桡骨头脱位；Colles骨折为伸直型桡骨远端骨折，远端向手背、桡侧移位；Barton骨折为桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位。[源:考研真题 GS-2014-149]

---

226. [A1型题 | 理解] batch032_M7_A1_003

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2013-088

儿童肘部外伤后，鉴别肱骨髁上骨折和肘关节脱位最可靠的体征是

- A. 肿胀明显
- B. 活动明显受限
- C. 局部畸形
- D. 肘后三角关系改变 ✅

- E. 肘关节弹性固定

答案：D

> 解析：无论肱骨髁上骨折还是肘关节脱位，均可出现局部明显肿胀、活动受限、局部畸形，故不答A、B、C。肱骨髁上骨折未累及肘关节，肘后三角关系无改变；肘关节脱位后肘后三角关系肯定有改变，是两者临床鉴别要点。肘后三角由内、外髁与尺骨鹰嘴组成。[源:考研真题 GS-2013-088]

---

227. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_004

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2006-103

桡骨远端骨折，骨折线经关节面，远端骨折片向背侧移位，该骨折诊断为

- A. Colles骨折
- B. Smith骨折
- C. Barton骨折 ✅
- D. Monteggia骨折
- E. Galeazzi骨折

答案：C

> 解析：Barton骨折指桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位，表现为与Colles骨折相似的畸形和体征，X线平片可发现桡骨远端背侧缘关节面骨折，腕关节随骨折块一起向背侧、近侧移位。Colles为伸直型、远折端向背侧桡侧移位；Smith为屈曲型；孟氏为尺骨上1/3骨折合并桡骨头脱位；盖氏为桡骨干下1/3骨折合并尺骨小头脱位。[源:考研真题 GS-2006-103]

---

228. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_005

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2024-065

肱骨中下1/3骨折伴有桡神经损伤，可能丧失的运动功能是

- A. 屈腕、屈指并指
- B. 屈指、屈腕
- C. 伸指、并指
- D. 屈指、伸指

- E. 伸指、伸腕 ✅

答案：E

> 解析：桡神经损伤的典型临床表现是垂腕、垂指，即伸腕、伸指功能丧失，故答§。桡神经由肱骨中、下1/3段后外侧桡神经沟通过，此处骨折易损伤。[源:考研真题 GS-2024-065]

---

229. [A1型题｜应用] batch032_M7_A1_006

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2023-065

对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者，正确的处理顺序是

- A. 骨盆骨折—尿道损伤—休克
- B. 尿道损伤—休克—骨盆骨折
- C. 休克—骨盆骨折—尿道损伤 ✅
- D. 休克—尿道损伤—骨盆骨折
- E. 尿道损伤—骨盆骨折—休克

答案：C

> 解析：骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克，应优先处理失血性休克，因其可在短时间内危及生命；骨盆骨折常并发后尿道损伤，应积极处理骨盆骨折、纠正休克及电解质紊乱，待伤情稳定后再处理后尿道损伤。参阅北京大学医学出版社4版《外科学》P864。[源:考研真题 GS-2023-065]

---

230. [A1型题｜记忆] batch032_M7_A1_007

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2023-066

肩关节脱位发生率最高的类型是

- A. 后脱位
- B. 上脱位
- C. 前脱位 ✅
- D. 下脱位
- E. 盂下脱位

答案：C

> 解析：根据肱骨头脱位方向，肩关节脱位分为前脱位、后脱位、上脱位及下脱位四型，以前脱位最多见，占95%以上。前脱位时肱骨头可位于锁骨下、喙突下、肩前方或关节盂下。[源:考研真题 GS-2023-066]

---

231. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_008

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2023-106

肱骨干中、下1/3骨折若伴有桡神经损伤，临床上除骨折体征外，还可出现的体征是

- A. 伸腕功能存在、伸指功能丧失
- B. 伸指、伸腕功能丧失 ✅
- C. 屈指、屈腕功能丧失
- D. 屈指、伸指功能丧失
- E. 爪形手、骨间肌萎缩

答案：B

> 解析：肱骨干中、下1/3段后外侧有桡神经沟，内有桡神经通过，此处骨折易损伤桡神经，表现为伸腕、伸指功能丧失。拇指、示指屈曲障碍多见于正中神经损伤，环指小指远节屈曲障碍、屈腕障碍多见于尺神经损伤。[源:考研真题 GS-2023-106]

---

232. [A1型题 | 理解] batch032_M7_A1_009

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2022-066

下列不属于颈椎骨折合并高位截瘫并发症的是

- A. 呼吸道感染
- B. 泌尿道结石
- C. 心力衰竭 ✅
- D. 体温失调
- E. 骶尾部压疮

答案：C

> 解析：颈椎骨折合并高位截瘫的并发症包括呼吸衰竭、呼吸道感染、泌尿生殖道感染和结石、压疮、体温失调，不包括心力衰竭。[源:考研真题 GS-2022-066]

---

233. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_010

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2021-067

骨盆骨折最常见的并发症是

- A. 尿道损伤 ✅
- B. 膀胱损伤
- C. 肾脏损伤
- D. 直肠损伤
- E. 坐骨神经损伤

答案：A

> 解析：肾脏损伤不是骨盆骨折常见并发症，可首先排除；直肠损伤少见，为会阴部撕裂后果；骨盆骨折并发尿道损伤远比膀胱损伤多见，耻骨支骨折移位易引起尿道损伤，故答A。[源:考研真题 GS-2021-067]

---

234. [A1型题 | 理解] batch032_M7_A1_011

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2020-029

左下肢股骨干骨折固定6周后，左下肢明显比右下肢细。这种病变属于

- A. 压迫性萎缩
- B. 内分泌性萎缩
- C. 去神经性萎缩
- D. 损伤性萎缩
- E. 失用性萎缩 ✅

答案：E

> 解析：患者股骨干骨折固定6周，长期卧床不动，导致患肢肌肉失用性萎缩而变细。压迫性萎缩因组织器官长期受压所致；去神经性萎缩因运动神经元或轴突损害引起；损伤性萎缩常见于慢性炎症等。[源:考研真题 GS-2020-029]

---

235. [A1型题 | 理解] batch032_M7_A1_012

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2020-065

关于骨折的临床诊断，错误的是

- A. 畸形、反常活动、骨擦音
- B. 具其一即可诊断骨折
- C. 应诱发骨擦音以确诊 ✅
- D. 未见体征不能排除
- E. X线阴性即可排除

答案：C

> 解析：骨折特有体征包括畸形、异常活动、骨擦音或骨擦感，具有三种之一即可诊断；裂缝、嵌插、脊柱、骨盆骨折可无典型特有体征，不能排除骨折。体检发现特有体征有助于诊断，但不应有意诱发骨擦音或骨擦感，以免加重神经、血管损伤；X线阴性亦不能排除骨折。[源:考研真题 GS-2020-065]

---

236. [A1型题 | 理解] batch032_M7_A1_013

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2016-044

下列创伤中，能完全修复（完全再生）的是

- A. 周围神经断裂缝合
- B. 一期愈合的手术切口
- C. 二期愈合的手术切口
- D. 三度烧伤的创面
- E. 闭合性骨折 ✅

答案：E

> 解析：骨折愈合时，若对位对线达到解剖学复位，经骨板形成塑型期后可完全恢复原有组织结构和功能，属于完全再生（完全修复）。一期和二期愈合手术切口、三度烧伤创面愈合后有瘢痕形成，均非完全再生。[源:考研真题 GS-2016-044]

---

237. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_014

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2016-089

颈椎压缩骨折合并脱位首选的治疗方法是

- A. 颌枕带牵引
- B. 手法复位石膏固定
- C. 颅骨牵引 ✅
- D. 切开复位内固定
- E. 颈托外固定

答案：C

> 解析：颈椎压缩骨折合并脱位首选颅骨牵引复位。颌枕带牵引常用于稳定型颈椎骨折轻度压缩；颈椎骨折手法复位困难；切开复位常用于合并四肢瘫痪及牵引失败者。[源:考研真题 GS-2016-089]

---

238. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_015

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2015-090

骨盆骨折早期最危险的并发症是

- A. 膀胱、尿道破裂
- B. 坐骨神经损伤
- C. 直肠损伤
- D. 出血性休克 ✅
- E. 腹膜后血肿

答案：D

> 解析：骨盆为松质骨，邻近髂内、髂外动静脉分支，血液供应丰富，骨盆骨折可引起广泛性出血，出血量可达500～5000ml，造成失血性休克，是骨盆骨折最危险、导致死亡最重要的并发症。膀胱尿道破裂、坐骨神经损伤、直肠损伤虽可发生，但均非最危险。[源:考研真题 GS-2015-090]

---

239. [A1型题 | 记忆] batch032_M7_A1_016

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2012-044

下列骨折愈合描述中，骨折处表现为肉芽组织和排列紊乱的骨小梁的是

- A. 纤维性骨痂形成
- B. 血肿机化期
- C. 骨不愈合
- D. 骨痂重塑完成
- E. 骨性骨痂形成 ✅

答案：E

> 解析：骨性骨痂形成期由纤维性骨痂分化出骨母细胞形成类骨组织，类骨组织转变为编织骨，编织骨结构不致密、骨小梁排列紊乱，故答§。血肿机化为肉芽组织；纤维性骨痂为纤维连接；重塑期编织骨改建成板层骨。[源:考研真题 GS-2012-044]

---

240. [A1型题 | 理解] batch032_M7_A1_017

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2011-088

下列关于股骨颈骨折的叙述，错误的是

- A. 老年患者不易发生坏死 ✅
- B. 头下型易出现坏死
- C. 基底型不易出现坏死
- D. 坏死可发生于数年后
- E. 基底型愈合较快

答案：A

> 解析：20%～30%股骨颈骨折后发生股骨头缺血坏死，好发于老年人。头下型骨折易损伤旋股内、外侧动脉，易出现缺血坏死；基底型骨折有旋股内、外侧动脉分支供血，不易坏死、易愈合；缺血坏死最早伤后1.5个月、最晚17年发生。故A错误。[源:考研真题 GS-2011-088]

---

241. [A1型题｜理解] batch032_M7_A1_018

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2009-088

胫骨下1/3处骨折，愈合较慢的原因是

- A. 附近主要血管损伤
- B. 附近周围神经损伤
- C. 远侧段血供完全丧失
- D. 远侧段血供减弱 ✅
- E. 骨膜损伤严重

答案：D

> 解析：胫骨营养血管从胫骨干上、中1/3交界处进入骨内，胫骨下1/3处骨折使营养动脉损伤，导致下1/3段胫骨血供显著减少；且下1/3段几乎无肌附着，血液循环少，故愈合较慢，易发生延迟愈合或不愈合。[源:考研真题 GS-2009-088]

---

242. [A1型题｜理解] batch032_M7_A1_019

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P620

成人骨折愈合过程中，原始骨痂形成期一般约需多长时间

- A. 1～2周
- B. 2～4周
- C. 3～6个月 ✅
- D. 6～8个月
- E. 1～2年

答案：C

> 解析：成人原始骨痂形成期一般约需3～6个月；血肿炎症机化期约2周完成纤维连接；骨痂改造塑形期约需1～2年。参阅教材P620。

---

243. [A1型题｜理解] batch032_M7_A1_020

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P622

下列关于骨折功能复位标准的叙述，正确的是

- A. 旋转移位、分离移位可不完全矫正
- B. 成角移位无须完全复位
- C. 长骨干横形骨折对位至少达1/3 ✅
- D. 干骺端骨折对位至少达1/4
- E. 肱骨干骨折对线不良可接受

答案：C

> 解析：功能复位标准：旋转移位、分离移位必须完全矫正；成角移位必须完全复位，否则易引起创伤性关节炎，肱骨干骨折稍有畸形对功能影响不大；长骨干横形骨折对位至少达1/3，干骺端骨折至少对位3/4。参阅教材P622。

---

244. [A1型题｜理解] batch032_M7_A1_021

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P618

骨筋膜隔室综合征患者，提示应及时行筋膜切开减压手术的指征是

- A. 筋膜室压力大于20mmHg
- B. 筋膜室压力大于30mmHg ✅
- C. 舒张压减室压大于40mmHg
- D. 患肢肿胀、皮温正常
- E. 被动牵拉肌肉轻度疼痛

答案：B

> 解析：骨筋膜隔室综合征若筋膜室压力大于30mmHg，或梯度压力（舒张压－筋膜室压力）小于30mmHg，应及时行筋膜切开减压手术。早期四个体征：感觉异常、被动牵拉痛、主动屈曲痛、肌腹压痛。参阅教材P618。

---

245. [A1型题｜理解] batch032_M7_A1_022

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P626

开放性骨折清创术的黄金时间通常是伤后

- A. 1～2小时
- B. 3～4小时
- C. 6～8小时 ✅
- D. 12～16小时
- E. 24～48小时

答案：C

> 解析：开放性骨折原则上清创越早感染机会越少，通常伤后6～8小时内是清创黄金时间，此时污染伤口细菌尚未侵入深部组织，彻底清创后绝大多数可一期愈合；超过8小时感染可能性增大，24小时内有效使用抗生素仍可清创。参阅教材P626。

---

246. [A1型题｜应用] batch032_M7_A1_023

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P629

锁骨骨折多发生的部位是

- A. 内侧1/3
- B. 中1/3 ✅
- C. 外侧1/3
- D. 肩锁关节
- E. 胸锁关节

答案：B

> 解析：锁骨骨折一般分为三型：中1/3骨折约占全部80%，外侧1/3约占15%，内侧1/3仅占5%。中1/3骨折因胸锁乳突肌牵拉近折端向上后移位，远折端因上肢重力及胸大肌牵拉向前下移位。参阅教材P629。

---

247. [A1型题｜应用] batch032_M7_A1_024

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P635

关于儿童肱骨髁上骨折，下列说法中正确的是

- A. 伸直型占约50%
- B. 屈曲型占约97%
- C. 伸直型占约97% ✅
- D. 多发生于10岁以上儿童
- E. 近折端向后下移位易压迫尺神经

答案：C

> 解析：肱骨髁上骨折多发生于10岁以下儿童，按暴力和移位方向分屈曲型和伸直型，其中伸直型占97%。伸直型近折端向前下移位、远折端向上移位，近折端易压迫或刺破肱动脉，并可继发前臂骨筋膜隔室综合征。参阅教材P635。

---

248. [A1型题｜分析] batch032_M7_A1_025

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P652

成人股骨头最主要的血液供应来源是

- A. 股骨头圆韧带小凹动脉
- B. 股骨干滋养动脉升支
- C. 旋股内侧动脉分支 ✅
- D. 旋股外侧动脉分支
- E. 闭孔动脉分支

答案：C

> 解析：成人股骨头血供包括小凹动脉、股骨干滋养动脉升支和旋股内外侧动脉分支；其中旋股内侧动脉发出的骺外侧动脉供应股骨头2/3～4/5区域，是最主要供血来源。旋股内侧动脉损伤是导致股骨头缺血坏死的主要原因，故头下型骨折最易发生坏死。参阅教材P652。

---

249. [A1型题 | 分析] batch032_M7_A1_026

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：教材P679

关于脊柱骨折的急救搬运，下列做法正确的是

- A. 一人抬头一人抬脚
- B. 单人搂抱搬运
- C. 木板平托或滚动搬运 ✅
- D. 屈曲躯干搬运
- E. 徒手拖拽双下肢

答案：C

> 解析：脊柱骨折急救严禁一人抬头一人抬脚或搂抱，以免脊柱弯曲使碎骨片向后挤入椎管加重脊髓损伤；正确方法为采用担架、木板，平托法或滚动法使伤员保持平直整体搬运，并注意保持颈部稳定。参阅教材P679。

---

250. [A2型题 | 应用] batch032_M7_A2_001

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2022-067

女性,56岁。车祸伤，右髋痛，右下肢变短，活动明显受限2小时来诊。检查见右髋关节屈曲、内收、内旋。最可能的诊断是

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨转子骨折
- C. 髋关节后脱位 ✅
- D. 髋关节前脱位
- E. 髋臼骨折

答案：C

> 解析：髋关节后脱位常表现为患肢短缩，髋关节呈屈曲、内收、内旋畸形，故答C。髋关节前脱位表现为患肢稍延长、屈曲外展外旋畸形；股骨颈骨折表现为患肢短缩、外旋45°～60°畸形；股骨转子骨折表现为患肢短缩、外旋90°畸形。参阅教材P650。

---

251. [A2型题 | 应用] batch032_M7_A2_002

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2018-103

男性，40岁。高处坠落伤，胸背部疼痛，双下肢不能活动。首先考虑的是

- A. 脊柱损伤合并骨盆骨折
- B. 胸部损伤合并骨盆骨折
- C. 脊柱损伤合并双下肢骨折
- D. 脊柱损伤合并脊髓损伤 ✅
- E. 脊髓损伤合并颅脑损伤

答案：D

> 解析：患者高处坠落、胸背部疼痛，提示受伤部位在胸背部；双下肢不能活动，应考虑胸椎骨折合并脊髓损伤，故答§。脊柱损伤合并骨盆骨折或双下肢骨折、胸部损伤合并骨盆骨折均不能以一元论解释。最有价值检查为MRI。参阅教材P678。

---

252. [A2型题 | 应用] batch032_M7_A2_003

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2017-065

男性，80岁。摔伤致右髋部疼痛2天。X线检查见右侧股骨颈头下型骨折，有移位。比较恰当的治疗是

- A. 下肢皮牵引
- B. 全髋关节置换
- C. 股骨颈闭合复位固定
- D. 卧床穿防旋鞋
- E. 人工股骨头置换 ✅

答案：E

> 解析：65岁以上老年人股骨颈头下型骨折，股骨头血液循环已严重破坏，缺血坏死发生率很高，宜采用人工股骨头置换术。皮牵引、卧床休息、防旋转鞋适用于全身情况差不能耐受手术者；闭合复位内固定适用于65岁以下有移位股骨颈骨折。参阅教材P654。

---

253. [A2型题 | 应用] batch032_M7_A2_004

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2012-089

某篮球运动员，起跳抢球时与对方球员相撞，即感右髂部疼痛，下肢活动受限。X线显示右髂前上棘撕脱骨折。其骨折成因为

- A. 直接暴力所致
- B. 病理性骨折
- C. 疲劳性骨折
- D. 间接暴力所致 ✅
- E. 医源性骨折

答案：D

> 解析：缝匠肌起于髂前上棘，起跳时屈髋屈膝使缝匠肌猛烈收缩，导致髂前上棘撕脱性骨折，为间接暴力（肌肉牵拉力）所致。疲劳性骨折常发生于第2、3跖骨及腓骨下1/3；病理性骨折因骨骼本身病变、轻微外力所致。参阅教材P629。

---

254. [A2型题 | 应用] batch032_M7_A2_005

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2010-089

男性,20岁，右肱骨干骨折2个月，外固定已拆除。提示骨折已愈合的临床表现是

- A. 骨折线模糊有骨痂 ✅
- B. 局部轻微异常活动
- C. 骨折处有纵向叩痛
- D. 平举0.5kg达1分钟
- E. 局部无纵向叩击痛

答案：A

> 解析：骨折临床愈合标准：①局部无压痛及纵向叩击痛；②局部无异常活动；③X线显示骨折处有连续性骨痂、骨折线模糊（A对）；④拆除外固定后上肢能平举1kg重物持续1分钟。B、C为有异常活动/叩痛，提示未愈合；D仅0.5kg且不足标准；A为最具决定性的影像标准。参阅教材P621。

---

255. [A2型题｜应用] batch032_M7_A2_006

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P660

男性,30岁。跌倒时膝部跪地，即感膝前剧烈疼痛、肿胀，膝关节主动活动障碍。查体：膝前可扪及骨折分离凹陷，髌骨区压痛明显，无膝关节脱位体征。X线正侧位片示髌骨横形骨折，移位约3mm。最可能的诊断是

- A. 髌骨软化症
- B. 股骨髁骨折
- C. 膝关节脱位
- D. 胫骨平台骨折
- E. 髌骨骨折 ✅

答案：E

> 解析：患者跌倒跪地、股四头肌猛烈收缩致髌骨横形骨折，膝前肿胀、可扪及骨折分离凹陷为典型表现；X线已明确髌骨横形骨折且移位<5mm，首选伸直位石膏托或支具固定4～6周，6周后开始功能锻炼。参阅教材P660。

---

256. [B1型题｜理解] batch032_M7_B1_001

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P654

老年女性跌倒后髋部疼痛、伤肢短缩，股骨颈骨折的典型畸形为

- A. 屈曲、内收、内旋畸形，下肢短缩
- B. 外旋45°～60°畸形，下肢短缩 ✅
- C. 外旋90°畸形，下肢短缩
- D. 外展、外旋、屈曲畸形
- E. 患肢短缩、髋部肿胀

答案：B

> 解析：股骨颈骨折伤后下肢外旋畸形一般为45°～60°，因骨折远端失去关节囊及髂股韧带稳定作用，臀中肌、臀小肌及臀大肌牵拉、内收肌群牵拉导致外旋。若外旋达90°应怀疑股骨转子间骨折。参阅教材P654。

---

257. [B1型题｜应用] batch032_M7_B1_002

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P656

股骨转子间骨折因附着肌群牵拉，下肢外旋畸形可达

- A. 屈曲、内收、内旋畸形，下肢短缩
- B. 外旋45°～60°畸形，下肢短缩
- C. 外旋90°畸形，下肢短缩 ✅
- D. 外展、外旋、屈曲畸形
- E. 患肢短缩、髋部肿胀

答案：C

> 解析：股骨转子间骨折转子区疼痛、肿胀、瘀斑，下肢外旋畸形明显可达90°，有轴向叩击痛，与股骨颈骨折（外旋45°～60°）鉴别。参阅教材P656。

---

258. [B1型题｜理解] batch032_M7_B1_003

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P668

腓骨颈骨折移位时易损伤的神经是

- A. 桡神经损伤（垂腕、伸指障碍）
- B. 正中神经损伤（猿手、桡侧感觉障碍）
- C. 尺神经损伤（爪形手、尺侧感觉障碍）
- D. 腓总神经损伤（足下垂、足背感觉障碍） ✅
- E. 坐骨神经损伤（弛缓性瘫痪、马鞍区障碍）

答案：D

> 解析：腓总神经由腘窝后外侧斜向下外方，经腓骨颈进入腓骨长、短肌及小腿前方肌群，移位的腓骨颈骨折可引起腓总神经损伤，表现为足下垂、趾背伸无力及足背外侧感觉障碍。参阅教材P668。

---

259. [B1型题｜应用] batch032_M7_B1_004

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：教材P650

髋关节后脱位约10%合并的神经损伤，多表现为以腓总神经为主的体征，其受损神经是

- A. 桡神经损伤（垂腕、伸指障碍）
- B. 正中神经损伤（猿手、桡侧感觉障碍）
- C. 尺神经损伤（爪形手、尺侧感觉障碍）
- D. 腓总神经损伤（足下垂、足背感觉障碍）
- E. 坐骨神经损伤（弛缓性瘫痪、马鞍区障碍） ✅

答案：E

> 解析：髋关节后脱位约10%合并坐骨神经损伤，多为神经受牵拉引起的暂时性功能障碍，多表现为以腓总神经为主的体征（足下垂等），但受损的神经本身是坐骨神经。大多数病人可于伤后逐渐恢复。参阅教材P650。

---

260. [X型题｜理解] batch032_M7_X_001

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2015-179

胸腰椎骨折的临床表现包括

- A. 畸形、后凸、弧度消失 ✅
- B. 脊柱功能障碍 ✅
- C. 异常活动及骨擦音
- D. 疼痛及局部肿胀 ✅

答案：ABD

> 解析：胸腰椎骨折体检可发现脊柱后凸畸形、生理弧度消失；躯干活动受限、功能障碍；局部疼痛及肿胀。异常活动及骨擦音为骨折特有体征，但裂缝、嵌插、脊柱、骨盆骨折可无异常活动及骨擦音，故不答C。[源:考研真题 GS-2015-179]

---

261. [X型题 | 记忆] batch032_M7_X_002

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2022-164

骨折的早期并发症包括

- A. 脂肪栓塞 ✅
- B. 坠积性肺炎
- C. 神经损伤 ✅
- D. 急性骨萎缩

答案：AC

> 解析：脂肪栓塞、神经损伤属于骨折的早期并发症；坠积性肺炎、急性骨萎缩属于骨折的晚期并发症，不应误答D。[源:考研真题 GS-2022-164]

---

262. [X型题 | 理解] batch032_M7_X_003

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折 | 页码：考研真题/GS-2018-164

关于肱骨外科颈骨折，下列说法正确的有

- A. 多见于中老年人 ✅
- B. 可合并血管神经损伤 ✅
- C. 可合并肱骨头碎裂骨折 ✅
- D. 有侧方和成角移位者须手术治疗

答案：ABC

> 解析：肱骨外科颈骨折可发生于任何年龄，但多见于中老年人，尤其骨质疏松者；其位于解剖颈下2～3cm，有臂丛神经、腋血管内侧经过，可合并神经、血管损伤；可合并肱骨头碎裂骨折。侧方移位和成角移位主要采用手法复位、外固定治疗，无须手术。[源:考研真题 GS-2018-164]

263. [X型题｜记忆] batch032_M7_X_004

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2017-164

骨折的特有体征有

- A. 局部压痛
- B. 骨擦音 ✅
- C. 成角畸形 ✅
- D. 局部肿胀

答案：BC

> 解析：骨折的特有体征包括局部畸形、异常活动、骨擦音或骨擦感；成角畸形属畸形，骨擦音属特有体征。局部压痛、局部肿胀为骨折一般表现，无论骨折或软组织损伤均可出现，不属于特有体征。[源:考研真题 GS-2017-164]

---

264. [X型题｜理解] batch032_M7_X_005

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2016-179

髌骨骨折的治疗原则有

- A. 解剖复位，保持关节面平整 ✅
- B. 尽可能保留髌骨 ✅
- C. 稳定固定情况下早期活动 ✅
- D. 屈曲位膝关节固定

答案：ABC

> 解析：髌骨骨折治疗原则：争取解剖学复位、恢复关节面平整（A对）；尽可能保留髌骨以维持原有功能（B对）；稳定固定下早期锻炼股四头肌、练习膝关节屈伸（C对）。髌骨骨折应保持膝关节伸直位固定，D错。[源:考研真题 GS-2016-179]

---

265. [X型题｜记忆] batch032_M7_X_006

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2011-179

可不出现骨折特有体征的骨折有

- A. 裂缝骨折 ✅
- B. 嵌插骨折 ✅
- C. 青枝骨折 ✅
- D. 不完全骨折 ✅

答案：ABCD

> 解析：骨折专有体征包括局部畸形、反常活动和骨擦音/骨擦感，一般见于完全性骨折；但裂缝骨折、嵌插骨折、青枝骨折、不完全骨折均可不出现骨折专有体征。[源:考研真题 GS-2011-179]

---

266. [X型题｜理解] batch032_M7_X_007

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2010-180

下列骨折中，治疗需要达到解剖复位的有

- A. 三踝骨折 ✅
- B. 肱骨干骨折
- C. 肱骨髁间骨折 ✅
- D. 胫骨平台骨折 ✅

答案：ACD

> 解析：三踝骨折、肱骨髁间骨折、胫骨平台骨折均为关节内骨折，为避免后遗创伤性关节炎，治疗应达到解剖复位。肱骨干骨折不属于关节内骨折，达到功能复位即可。[源:考研真题 GS-2010-180]

---

267. [X型题｜理解] batch032_M7_X_008

> 模块：骨折、关节损伤、脊柱脊髓损伤、骨盆骨折丨页码：考研真题/GS-2009-180

骨折切开复位的适应证有

- A. 关节内骨折，手法未能完全复位 ✅
- B. 闭合骨折，并有大血管损伤 ✅
- C. 闭合骨折，未达到解剖复位
- D. 手法复位失败，疑断端有软组织嵌入 ✅

答案：ABD

> 解析：切开复位适应证：关节内骨折手法未能完全复位（A对）；合并大血管损伤应立即手术（B对）；手法复位失败、疑有软组织嵌入者应切开（D对）。骨折后只要达到功能复位标准，即使未达解剖复位，愈合后不影响功能，不答C。[源:考研真题 GS-2009-180]

骨与关节化脓性感染、骨肿瘤（30题）

268. [A1型题 | 记忆] batch032_M8_A1_001

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P731

急性血源性骨髓炎最常发生的部位是

- A. 长骨干骺端 ✅
- B. 长骨骨干
- C. 长骨骨骺
- D. 干骺端骨骺板
- E. 骨膜下间隙

答案：A

> 解析：急性血源性骨髓炎好发于长骨干骺端，因干骺端血流缓慢、终末动脉易形成血栓，且儿童骨骺板屏障使脓液较少进入关节。参阅教材P731。

---

269. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_002

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P732

急性血源性骨髓炎早期诊断最有意义的方法是

- A. X线平片检查
- B. 局部分层穿刺 ✅
- C. 血沉测定
- D. CT扫描
- E. 放射性核素骨扫描

答案：B

> 解析：局部分层穿刺在压痛最明显处边进针边抽吸，涂片见脓细胞或细菌即可明确诊断，是早期诊断的关键；X线平片起病约2周内多无异常发现，不能作为早期诊断依据。参阅教材P732。

---

270. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_003

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P732

急性化脓性骨髓炎全身抗生素治疗的原则是

- A. 晚期、单一、小量、短程
- B. 首选窄谱抑菌药
- C. 仅在手术前短期使用
- D. 症状好转即停药
- E. 早期、联合、足量、全程 ✅

答案：E

> 解析：抗生素应早期、联合、足量、全程使用；疑诊即开始，培养结果出来前联合覆盖革兰阳性球菌与广谱菌，持续用到症状和体征消失、血象正常及引流液清亮。参阅教材P732。

---

271. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_004

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P733

慢性化脓性骨髓炎最具特征性的X线表现是

- A. 软组织积气
- B. 普遍性骨质疏松
- C. 密度增高的死骨伴包壳 ✅

- D. 关节间隙增宽
- E. 线性骨膜钙化

答案：C

> 解析：慢性骨髓炎X线典型表现为密度增高的死骨，边缘不规则，其周围有透光带（死腔），新生骨形成硬化的包壳将死骨包裹；骨干变粗、骨皮质密度不均。参阅教材P733。

---

272. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_005

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P733

慢性骨髓炎出现下列哪种情况时不宜行病灶清除术

- A. 有死骨形成
- B. 窦道流脓经久不愈
- C. 急性发作期 ✅
- D. 死腔较大
- E. 包壳已充分形成

答案：C

> 解析：慢性骨髓炎急性发作期不宜行病灶清除术，应以抗生素治疗为主、积脓时切开引流；有大块死骨而包壳尚未充分形成者亦不宜过早摘除，以免造成长段骨缺损。参阅教材P733。

---

273. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_006

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P733

局限性骨脓肿（Brodie脓肿）最常发生于

- A. 脊柱椎体
- B. 长骨骨干
- C. 骨盆扁骨
- D. 长骨干骺端 ✅
- E. 短骨骨干

答案：D

> 解析：局限性骨脓肿（Brodie脓肿）是包围在骨质内的局限性骨内脓肿，通常发生于长骨干骺端，以胫骨、股骨和肱骨多见；X线表现为骨内囊性病变伴周围硬化骨包绕。参阅教材P733。

---

274. [A1型题 | 记忆] batch032_M8_A1_007

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P736

化脓性关节炎最常见的致病菌是

- A. 肺炎支原体
- B. 大肠埃希菌
- C. 结核分枝杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌 ✅
- E. 乙型溶血性链球菌

答案：D

> 解析：化脓性关节炎常见致病菌为金黄色葡萄球菌，约占85%，其他还有乙型溶血性链球菌、白色葡萄球菌、淋病奈瑟球菌、肺炎球菌和肠道杆菌等。参阅教材P736。

---

275. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_008

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P736

化脓性关节炎的病理演变过程不包括下列哪一分期

- A. 浆液性渗出期
- B. 浆液纤维素性渗出期
- C. 脓性渗出期
- D. 干酪样坏死期 ✅
- E. 以上均为其分期

答案：D

> 解析：化脓性关节炎病理分浆液性渗出期、浆液纤维素性渗出期、脓性渗出期三期；干酪样坏死是骨与关节结核的特征性病变，不属于化脓性关节炎的病理分期。参阅教材P736。

---

276. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_009

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P736

化脓性关节炎浆液性渗出期关节穿刺液的特点是

- A. 黄白色脓性
- B. 清亮、白细胞少 ✅
- C. 血性混浊液
- D. 草绿色混浊
- E. 米汤样液体

答案：B

> 解析：化脓性关节炎关节液随病理期由清亮（浆液性）变为混浊（浆液纤维素性）再至黄白色（脓性）；浆液性渗出期液体清亮、白细胞少，如治疗及时可完全吸收不留障碍。参阅教材P736。

---

277. [A1型题 | 记忆] batch032_M8_A1_010

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P739

骨与关节结核中最常见的发病部位是

- A. 脊柱 ✅
- B. 髋关节
- C. 膝关节
- D. 肘关节
- E. 肩关节

答案：A

> 解析：骨与关节结核是最常见的肺外继发性结核，其中脊柱结核最多见，约占50%以上，其次为髋、膝关节结核各约15%。参阅教材P739。

278. [A1型题 | 记忆] batch032_M8_A1_011

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P740

骨与关节结核形成的无红、热急性炎症表现的脓肿称为

- A. 寒性脓肿 ✅
- B. 蜂窝织炎
- C. 搏动性脓肿
- D. 化脓性脓肿
- E. 张力性脓肿

答案：A

> 解析：骨与关节结核病灶积聚脓液、肉芽组织、死骨和干酪样坏死，因无红、热等急性炎症反应，称为冷脓肿或寒性脓肿；可向体表溃破成窦道，或与空腔脏器沟通形成内瘘。参阅教材P740。

---

279. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_012

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P741

骨与关节结核化疗中首选的抗结核药物是

- A. 异烟肼与利福平 ✅
- B. 链霉素与乙胺丁醇
- C. 吡嗪酰胺单用
- D. 氨硫脲与对氨基水杨酸
- E. 喹诺酮类单用

答案：A

> 解析：骨与关节结核化疗首选异烟肼（INH）与利福平（RFP）；链霉素因对第Ⅷ对脑神经毒性强烈，现已不列为首选药物。参阅教材P741。

---

280. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_013

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P741

判断骨与关节结核临床治愈时，血沉检查应满足

- A. 1次正常即可
- B. 连续3次正常 ✅
- C. 较正常值升高
- D. 仅需下降未必要正常
- E. 不必复查血沉

答案：B

> 解析：骨与关节结核治愈标准包括连续3次血沉检查均正常，且全身情况良好、局部症状消失、窦道闭合、影像学好转、起床活动1年仍稳定。参阅教材P741。

---

281. [A1型题 | 记忆] batch032_M8_A1_014

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P746

检查髋关节有无屈曲畸形常用的体征是

- A. “4”字试验
- B. 托马斯征 ✅
- C. 浮髌试验
- D. 拾物试验
- E. 直腿抬高试验

答案：B

> 解析：托马斯（Thomas）征用于检查髋关节有无屈曲畸形：健侧髋膝屈曲贴胸使腰椎贴床，若患侧下肢不能伸直平放即为阳性，其与床面所成角度即为屈曲畸形角度。参阅教材P746。

---

282. [A1型题 | 理解] batch032_M8_A1_015

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P748

发病率仅次于脊柱结核的骨与关节结核是

- A. 髋关节结核
- B. 肩关节结核
- C. 肘关节结核
- D. 骶髂关节结核
- E. 膝关节结核 ✅

答案：E

> 解析：膝关节结核发病率居全身骨与关节结核第二位，仅次于脊柱结核，多见于儿童和青少年，单纯滑膜结核较单纯骨结核常见。参阅教材P748。

---

283. [A2型题｜应用] batch032_M8_A2_001

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤｜页码：教材P731

男孩，9岁。高热、寒战2天，右小腿近端剧痛，拒按，局部皮温高，深压痛明显，不愿活动。白细胞计数及中性粒细胞比例明显升高。最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 骨软骨瘤
- C. 类风湿关节炎
- D. 腰椎间盘突出症
- E. 急性血源性骨髓炎 ✅

答案：E

> 解析：儿童高热寒战、长骨干骺端剧痛深压痛、白细胞升高，符合急性血源性骨髓炎；骨软骨瘤为无痛性骨性包块，骨关节炎与类风湿多见于成人，腰椎间盘突出以放射痛为主。参阅教材P731。

---

284. [A2型题｜应用] batch032_M8_A2_002

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤｜页码：教材P746

女孩，7岁。右髋部隐痛、跛行3个月，伴低热、盗汗、乏力。查体：“4”字试验阳性，托马斯征阳性。X线示髋关节间隙变窄、股骨头边缘骨质破坏。最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 强直性脊柱炎
- C. 化脓性髋关节炎
- D. 股骨头骨软骨病
- E. 髋关节结核 ✅

答案：E

> 解析：儿童慢性髋痛、低热盗汗、4字试验及Thomas征阳性、X线关节间隙变窄与边缘骨破坏，典型为髋关节结核；化脓性关节炎起病急骤高热，类风湿多对称累及小关节。参阅教材P746。

---

285. [A2型题 | 应用] batch032_M8_A2_003

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P736

青年，男，25岁。右膝红肿热痛、高热39.5℃、不敢活动2天。查体：膝关节半屈曲位，髌上囊隆起，浮髌试验阳性。关节穿刺液黄白色、镜检大量脓细胞。最可能的诊断是

- A. 膝关节结核
- B. 痛风性关节炎
- C. 骨关节炎
- D. 类风湿关节炎
- E. 化脓性关节炎 ✅

答案：E

> 解析：单膝急骤红热肿痛、高热、浮髌试验阳性、穿刺液黄白色含大量脓细胞，符合化脓性关节炎；结核起病缓、穿刺液清→混，痛风多见于第一跖趾关节。参阅教材P736。

---

286. [A2型题 | 应用] batch032_M8_A2_004

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P750

女性，62岁。双膝关节隐痛多年，上下楼加重，晨僵约15分钟，手指远端指间关节肿大并触及结节。X线示膝关节非对称性间隙变窄、边缘骨赘。最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 银屑病关节炎
- C. 痛风性关节炎
- D. 强直性脊柱炎
- E. 骨关节炎 ✅

答案：E

> 解析：中老年患者膝关节负重痛、晨僵<30分钟、Heberden结节、X线非对称性间隙变窄与骨赘，符合骨关节炎；类风湿晨僵>1小时、多对称小关节、类风湿因子阳性。参阅教材P750。

---

287. [B1型题｜记忆] batch032_M8_B1_001

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤｜页码：教材P739

在骨与关节结核中，发病率最高的发病部位是：

- A. 脊柱 ✅
- B. 髋关节
- C. 膝关节
- D. 肘关节
- E. 踝关节

答案：A

> 解析：脊柱结核发病率占骨与关节结核首位，约占50%以上，绝大多数发生于椎体，附件结核仅1%～2%。参阅教材P739。

---

288. [B1型题｜记忆] batch032_M8_B1_002

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤｜页码：教材P748

2：发病率仅次于脊柱、居第二位的骨与关节结核是：

- A. 脊柱

- B. 髋关节
- C. 膝关节 ✅
- D. 肘关节
- E. 踝关节

答案：C

> 解析：膝关节结核发病率居全身骨与关节结核第二位，仅次于脊柱结核，儿童和青少年多见，多位于股骨下端和胫骨上端。参阅教材P748。

---

289. [X型题｜应用] batch032_M8_X_001

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤丨页码：教材P731

急性血源性骨髓炎的临床表现包括

- A. 寒战、高热至39℃以上 ✅
- B. 患肢剧痛、深压痛 ✅
- C. 干骺端早期即明显红肿
- D. 骨质广泛破坏后病理骨折 ✅
- E. 患肢关节常呈过度伸展位

答案：ABD

> 解析：急性血源性骨髓炎有寒战高热、患肢剧痛深压痛，骨质广泛破坏后可发生病理性骨折；但肿胀起初并不明显、数日后才显著，关节多呈半屈曲位而非过度伸展，故C、E不选。参阅教材P731。

---

290. [X型题｜应用] batch032_M8_X_002

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤丨页码：教材P733

慢性化脓性骨髓炎行病灶清除术的手术指征包括

- A. 有死骨形成 ✅
- B. 有死腔形成 ✅
- C. 窦道流脓经久不愈 ✅

- D. 包壳未形成的大块死骨
- E. 急性发作期

答案：ABC

> 解析：慢性骨髓炎手术指征为有死骨、死腔及窦道流脓；急性发作期应以抗生素为主、积脓时切开引流，包壳尚未充分形成时过早摘除大块死骨会造成长段骨缺损，故D、E为禁忌。参阅教材P733。

---

291. [X型题｜应用] batch032_M8_X_003

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤丨页码：教材P737

下列关于化脓性关节炎与关节结核鉴别的叙述，正确的有

- A. 化脓性关节炎起病急骤、高热 ✅
- B. 关节结核起病缓慢、低热 ✅
- C. 化脓性关节炎穿刺液清→混→脓性 ✅
- D. 关节结核穿刺液可发现抗酸杆菌 ✅
- E. 两者X线早期均有明显骨质破坏

答案：ABCD

> 解析：化脓性关节炎起病急骤高热、穿刺液清→混→脓性；关节结核起病缓慢低热、穿刺液清→混、可发现抗酸杆菌；二者X线早期均无明显变化，不能作为早期诊断依据，故E不选。参阅教材P737。

---

292. [X型题｜分析] batch032_M8_X_004

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤丨页码：教材P758

骨肿瘤的诊断应遵循的原则包括

- A. 临床、影像学与病理学三结合 ✅
- B. 溶骨性病变时血钙可升高 ✅
- C. 成骨性肿瘤碱性磷酸酶可升高 ✅
- D. 病理检查是最后确诊的唯一可靠检查 ✅

- E. 骨肿瘤治疗以手术为唯一有效手段

答案：ABCD

> 解析：骨肿瘤诊断必须临床、影像、病理三结合，病理检查是最后确诊唯一可靠检查；溶骨性病变血钙可升、成骨性肿瘤（如骨肉瘤）ALP升高有助判断；治疗应按Enneking外科分期选择，并非以手术为唯一手段，故E不选。参阅教材P758。

---

293. [X型题｜理解] batch032_M8_X_005

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤丨页码：教材P750

引起继发性骨关节炎的常见原因有

- A. 后天性关节面不平整 ✅
- B. 先天性关节结构异常 ✅
- C. 关节不稳定因素 ✅
- D. 下肢关节过度劳损

答案：ABC

> 解析：继发性骨关节炎发生于关节局部原有病变基础上，常见病因包括先天性关节结构异常、创伤、后天性关节面不平整、关节不稳定等；体重超重、下肢关节过于承重劳损为原发性骨关节炎的病因，故不答D。[源:考研真题 GS-2014-180]

---

294. [X型题｜理解] batch032_M8_X_006

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤丨页码：教材P751

不属于骨关节炎导致的畸形变有

- A. 杵状指畸形 ✅
- B. Heberden结节
- C. 手指向尺侧偏斜 ✅
- D. 天鹅颈样畸形 ✅

答案：ACD

> 解析：骨关节炎远端指间关节出现Heberden结节、近端出现Bouchard结节，故B属于骨关节炎畸形；杵状指见于慢性缺氧性疾病，手指尺侧偏斜与天鹅颈样畸形均为类风湿关节炎典型表现，均不属于骨关节炎。[源:考研真题 GS-2023-165]

---

295. [A1型题 | 应用] batch032_M8_A1_016

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P746

青年男性，28岁。长期低热、盗汗、乏力，右髋关节屈曲、活动受限，托马斯征阳性；右髋部触及肿物，血沉增快；X线示髋关节间隙变窄、关节面虫蚀样骨质破坏。最可能的诊断是

- A. 肺癌骨转移
- B. 髋关节骨关节炎
- C. 髋关节化脓性关节炎
- D. 全髋关节结核 ✅
- E. 类风湿关节炎

答案：D

> 解析：青年长期低热盗汗，髋关节屈曲活动受限、Thomas征阳性，右髋部寒性脓肿，X线示关节间隙变窄、关节面虫蚀样破坏，符合全髋关节结核；肺癌骨转移常累及脊柱，化脓性关节炎好发于儿童且高热，类风湿多为对称性小关节。[源:考研真题 GS-2017-103]

---

296. [A1型题 | 记忆] batch032_M8_A1_017

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P759

滤泡性淋巴瘤转化为弥漫大B细胞淋巴瘤的常见分子机制是

- A. TP53基因突变 ✅
- B. RAS基因突变
- C. BCL-ABL融合基因
- D. MYC基因扩增
- E. EWSR1融合基因

答案：A

> 解析：滤泡性淋巴瘤多起源于滤泡生发中心B细胞，特征性易位为t(14;18)致BCL-2活化；约40%可经TP53缺失突变、MLL2/EZH2/MEF2B突变等进展为弥漫大B细胞淋巴瘤，故答A；BCL-ABL见于慢粒，EWSR1-FLI1见于尤因肉瘤。[源:考研真题 GS-2013-052]

---

297. [B1型题｜记忆] batch032_M8_B1_003

> 模块：骨与关节化脓性感染、骨肿瘤 | 页码：教材P641

肘关节骨折后最易发生的并发症是：

- A. 缺血性骨坏死
- B. 骨化性肌炎 ✅
- C. 创伤性关节炎
- D. 关节僵硬
- E. 骨筋膜室综合征

答案：B

> 解析：骨化性肌炎又称损伤性骨化，是关节扭伤、脱位或邻近骨折后骨膜剥离形成血肿，处理不当致关节附近软组织广泛骨化，特别多见于肘关节（如肱骨髁上骨折）。[源:考研真题 GS-2013-149]

📌 图谱归属：题库与真题 MOC ｜ 知识图谱总览